

《黄帝内针讲义》 自学笔记

谢家树博士（香港）

2026-07-07

Table of contents

序言	1
上编：总论	3
第一章 第一章：黃帝內針的淵源與傳承複習精要	5
1.1 一、主要概念與理論	5
1.2 二、醫療實務示例要點（理論引申）	6
1.3 三、練習題核心考點	6
1.4 導讀：醫療實務建議	7
第二章 第二章：黃帝內針理法概述	9
2.1 一、主要概念與理論	9
2.2 第一節：三才、三焦	9
2.3 第二節：陰陽（六經辨證）	10
2.4 第三節：中和	10
2.5 二、醫療實務應遵循的核心原則	11
2.6 三、練習題核心考點（期末複習重點）	11
第三章 第三章：黃帝內針的基本特點	13
3.1 第一節：執兩用中	13

3.2	第二節：隨證治之	13
3.3	第三節：同氣相求	14
3.4	第四節：導引	15
3.5	第五節：神與形俱	15
3.6	醫療實務的進階建議	16
第四章	第四章：黃帝內針總則精要	17
4.1	第一節：方位治則（上病下治、下病上治、左病右治、右病左治）	17
4.2	第二節：核心靈魂——同氣相求	17
4.3	第三節：變通之道——陰陽倒換求	19
4.4	寄語：醫療實務的原則	20
第五章	第五章：黃帝內針用針規範	21
5.1	第一節：「三二一」規範	21
5.2	第二節：穴外定穴	22
5.3	總結：醫療實務的應用原則	22
第六章	第六章：黃帝內針用針注意事項	25
6.1	一、主要概念與理論	25
6.2	第一節：進針方法及特點	25
6.3	第二節：用針禁忌	25
6.4	第三節：暈針等的處理及預防	26
6.5	二、醫療實務示例要點（臨床情境模擬）	27
6.6	三、練習題核心考點	27
6.7	總結	27

下编：各论	29
第七章 下篇：各論概述	31
7.1 一、主要概念與理論：內針操作的核心算法	31
7.2 二、臨床實務導引要點：心物合一的轉化	31
7.3 三、療效提升的進階策略（強化方案）	32
7.4 四、醫案示例要點（臨床流程總結）	32
7.5 五、練習題核心考點	32
7.6 叮嚀：醫療實務建議	33
第八章 第一章：頭部	35
8.1 一、主要概念與理論	35
8.2 二、核心同氣對應表格（根據總則彙整）	35
8.3 三、醫案示例要點（臨床思維推導）	36
8.4 四、練習題核心考點	36
8.5 導讀：醫療實務建議	37
第九章 第二章：眼部	39
9.1 一、主要概念與理論	39
9.2 二、針治法則（第三節）	40
9.3 三、醫案示例要點（第四節）	40
9.4 四、練習題核心考點（第五節）	41
9.5 解說：醫療實務建議	41
第十章 第三章：耳部	43
10.1 一、主要概念與理論	43
10.2 二、針治法則（第三節）	44

10.3 三、醫案示例要點（第四節）	44
10.4 四、練習題核心考點（第五節）	45
10.5 導讀：醫療實務建議	45
第十一章 第四章：鼻部	47
11.1 一、主要概念與理論	47
11.2 二、針治法則（第三節）	48
11.3 三、醫案示例要點（第四節）	48
11.4 四、練習題核心考點（第五節）	49
11.5 解說：醫療實務建議	49
第十二章 第五章：脣口	51
12.1 一、主要概念與理論	51
12.2 二、針治法則（第三節）	52
12.3 三、醫案示例要點（第四節）	52
12.4 四、練習題核心考點（第五節）	53
12.5 解說：醫療實務建議	53
第十三章 第六章：面部	55
13.1 一、主要概念與理論	55
13.2 二、針治法則（第三節）	56
13.3 三、醫案示例要點（第四節）	56
13.4 四、練習題核心考點（第五節）	57
13.5 解說：醫療實務建議	57

第十四章 第七章：頸項	59
14.1 一、主要概念與理論	59
14.2 二、頸項經絡同氣對應表	60
14.3 三、針治法則（第三節）	60
14.4 四、醫案示例要點（第四節）	60
14.5 五、練習題核心考點（第五節）	61
14.6 解說：醫療實務建議	61
第十五章 第八章：咽喉	63
15.1 一、主要概念與理論	63
15.2 二、咽喉經絡同氣對應表	64
15.3 三、醫案示例要點	64
15.4 四、練習題核心考點	65
15.5 叮嚀：醫療實務建議	65
第十六章 第九章：肩部	67
16.1 一、主要概念與理論	67
16.2 二、肩部經絡同氣對應基準表	68
16.3 三、醫案示例要點（第四節）	68
16.4 四、練習題核心考點（第五節）	69
16.5 解說：醫療實務建議	69
第十七章 第十章：腰部	71
17.1 一、主要概念與理論	71
17.2 二、腰部經絡同氣對應基準表	72
17.3 三、醫案示例要點（第四節）	72

17.4 四、練習題核心考點（第五節）	73
17.5 解說：醫療實務建議	73
第十八章 第十一章：胸部	75
18.1 一、主要概念與理論	75
18.2 二、針治法則（第三節）	76
18.3 三、醫案示例要點（第四節）	76
18.4 四、練習題核心考點（第五節）	77
18.5 解說：醫療實務建議	77
第十九章 第十二章：腹部	79
19.1 一、主要概念與理論	79
19.2 二、腹部常用經絡同氣對應基準表	80
19.3 三、醫案示例要點	80
19.4 四、練習題核心考點	81
19.5 解說：醫療實務建議	81
第二十章 第十三章：手部	83
20.1 一、主要概念與理論（第一、二節）	83
20.2 二、針治法則（第三節）	84
20.3 三、醫案示例要點（第四節）	84
20.4 四、練習題核心考點（第五節）	85
20.5 解說：醫療實務建議	85
第二十一章 第十四章：足部	87
21.1 一、主要概念與理論	87
21.2 二、足部經絡同氣對應基準表（核心參考）	88

TABLE OF CONTENTS	ix
-------------------	----

21.3 三、針治法則（第三節）	89
21.4 四、醫案示例要點（第四節）	89
21.5 五、練習題核心考點（第五節）	89
21.6 解說：醫療實務建議	90

第二十二章 附錄：常用急救 91

22.1 第一節：毫針急救——理與法的核心	91
22.2 第二節：鋒針（三稜針）刺絡急救	91
22.3 第三節：艾灸急救——回陽救逆	92
22.4 第四節：指掐或提捏——無針時的應變	92
22.5 核心急救技術彙整表	93
22.6 導讀：醫療實務建議	93

序言

《黄帝内针讲义》的主編是刘力红教授，广西首位中医博士，现任广西中医药大学基础医学院教师，经典中医临床研究所首席教授。

「黄帝内针」针法源自《黄帝内经》。特色是“六经辨证、易学高效、技术安全”，屬於经络讲证针灸学派。《黄帝内针讲义》是医药院校的中医教学教材。

全书分为总论和各论。总论主要介绍了黄帝内针的理论体系和临床法则。各论按照疾病所在部位进行分类，详细论述了诊疗方法、医案示例，并附有练习题。

在下「攪車邊、撻衫尾」（沾光）学针灸。以下是在下自学笔记。

上编：总论

黃帝內針不僅僅是一種針法，它是一套完整的經絡辨證體系。在學習時，請暫時放下過去對「得氣」或「強刺激」的執著，因為內針追求的是「和平」與「中和」。

第一章 第一章：黃帝內針的淵源 與傳承複習精要

1.1 一、主要概念與理論

1. 學術淵源（第一節）：

- **理論根基**：黃帝內針源自中醫經典《黃帝內經》，是純正的經絡辨證針法派系。
- **核心特色**：強調「簡、便、驗、廉」，具備易學高效、技術安全的特點。
- **操作規範**：內針對進針範圍有極其嚴格的限制——**進針範圍嚴格限定在肘膝以下**。除非急救，否則軀幹部位、頭部及肘膝以上區域均為禁針區。
- **技術特點**：不追求提插捻轉，不講究針感得氣，其療效追求「猶拔刺也，如雪污也」，即立竿見影的轉化。

2. 傳承脈絡與修習要求（第二節）：

- **傳承途徑**：包含文字傳承（經典典籍）、口耳傳承（師徒相授）與直接傳承（心法領悟）。
- **醫者素養（三要素）**：
 - － **信**：確信內針的法脈與理路方計，這是修習的基石。
 - － **誠**：遵循天人合一，照章辦事，不隨意更改法度。
 - － **明**：對法理有透徹的把握。內針的技術極簡，但其理法至深，明理方能游刃有餘。

3. 理論依據（第三節）：

- 理法核心：源於《素問·陰陽應象大論》。
- 核心口訣：內針的總綱在於「善用針者，從陰引陽，從陽引陰，以右治左，以左治右」以及「陽病治陰，陰病治陽」。這套理論決定了內針在臨床取穴時的「異位同氣」邏輯。

1.2 二、醫療實務示例要點（理論引申）

雖然第一章以理論淵源為主，未列具體病案，但文中明確了臨床醫師應遵循的「轉化觀」：

- 非介入性干預：內針認為療效源於激發患者自身的「陰陽自和」。
- 療效標竿：若取穴正確（同氣相求），患者的痛楚或功能障礙應在進針當下即刻緩解（立竿見影）。
- 安全邊界：學生日後從事醫療實務時，必須嚴守「肘膝以下」的禁區。這種設計不僅是為了避開重要臟器，更是為了利用四肢末端最靈敏的「氣機窗口」。

1.3 三、練習題核心考點

1. 內針的定義與禁區：黃帝內針在一般臨床操作（非急救）中，絕對禁針的部位有哪些？（答案：肘膝以上區域、整個軀幹、頭部、患處病灶）。
2. 進針操作特色：內針法脈中，對於提插捻轉與針感（得氣）的要求為何？（答案：不需人為補瀉，不用提插捻轉，不講求得氣與否）。
3. 理論來源：黃帝內針的理論依據主要出自《黃帝內經》中的哪一篇文章？（答案：《素問·陰陽應象大論》）。
4. 醫者素養：傳承黃帝內針需要把握的三個要點是什麼？（答案：信、誠、明）。

1.4 導讀：醫療實務建議

1. **法理重於技術**：內針的針刺手法極其簡單，45 度斜刺即可。它真正的難點在於「辨經」與「定格」。你們未來的功夫要花在熟悉經絡巡行上。
2. **建立「和平」的醫療觀**：內針被稱為「和平的使者」，意指它不強攻病灶，而是透過末端的調整，引導全身陰陽回歸中道。在實務中，請務必保持心態的平和與專注。
3. **守住法脈的「誠」**：不要因為覺得好學就隨意發揮。內針的每一條法則（如左病右治、上病下取）都有其深刻的易理背景，照章辦事是你們通往進階之路的捷徑。

第二章 第二章：黃帝內針理法概述

2.1 一、主要概念與理論

2.2 第一節：三才、三焦

- 主要概念與理論：

- 三才觀：人生於天地之間，生命源於父母的因緣，更必須有「天地」的參與。這種「天人合一」的生命觀是內針法理的出發點。
- 三焦定位（臨床座標）：內針所引用的「三焦」與傳統解剖學上的腑器官不同，它是一套空間對應系統。
- 軀幹三焦界分表：

三焦層次	對應三才	軀幹具體區域
上焦	天	心窩（鳩尾穴）以上的區域
中焦	人	鳩尾穴至神闕穴（臍中）之間的區域
下焦	地	神闕穴以下的區域

- 初級至進階解說：

- 初級：你們必須學會第一眼看到病人時，先判斷病灶在哪個區域。心痛在上焦，胃痛在中焦，痛經在下焦。
- 進階：三焦是「三位一體」的。雖然界線明確，但臨床上「你有我，我有你」，針法的靈活在於突破死板的界線，體現空間的整體感。

2.3 第二節：陰陽（六經辨證）

- 主要概念與理論：

- 治病必求於本：本即陰陽。一切生命的變化、疾病的發生，本質上都是陰陽層面的變動。
- 「三而二之」與六經：這是內針最高深的思維。將三焦（三才）中每一部都各分陰陽，便構成了「六合」，即我們熟悉的三陰三陽（六經）。
- 內針六經導航表：

六經屬性	具體經脈名稱	六氣對應（進階層次）
手三陰經	手太陰肺經、手少陰心經、手厥陰心包經	-
手三陽經	手太陽小腸經、手陽明大腸經、手少陽三焦經	-
足三陰經	足太陰脾經、足少陰腎經、足厥陰肝經	厥陰風木、少陰君火、太陰濕土
足三陽經	足太陽膀胱經、足陽明胃經、足少陽膽經	少陽相火、陽明燥金、太陽寒水

- 醫案示例要點：

- 臨床醫師在診斷時，必須將「病」轉化為「經」。例如：一位病人前額痛，我們要識別出這是在「陽明經」；側頭痛是在「少陽經」。

2.4 第三節：中和

- 主要概念與理論：

- 「中」的作用：陰陽之所以能和諧相處、不走極端，是因為有「中」的作用。健康的人即是「平和之人」。
- 陰陽自和：內針治療的唯一目的，就是實現陰陽自和。正如張仲景所言：「陰陽自和者必自癒」。

- **醫者的內修（守中）**：進階的醫者必須「守神」於內，即是「守中」。抓住了「中」，就抓住了神機的根本。

2.5 二、醫療實務應遵循的核心原則

1. **定位為先（三焦原則）**：日後醫療實務，進針前第一步永遠是三焦定位。明確病灶是在天、人、地的哪一部。
2. **定性為要（六經原則）**：每一針、每一個念頭都不能離開六經辨證。只有辨清經脈，才能確保「同氣相求」的精準度。
3. **以和為期（目的原則）**：針刺不是為了「攻擊」疾病，而是為了「調和」。當你們在肘膝以下取穴時，要意識到這是在撥動生命的平衡盤，引導患者身體回歸中道。

2.6 三、練習題核心考點（期末複習重點）

1. **軀幹三焦的分界點**：請精確指出中焦的上下邊界點（答案：鳩尾穴與神闕穴）。
2. **「三而二之」的含義**：這句話如何解釋六經的來源？（答案：指在三才層面各分陰陽，形成三陰三陽的六經系統）。
3. **內針的最高宗旨**：針刺的目的為何？（答案：引導陰陽自和，實現中和）。

第二章是轉變為「中醫大腦」的關鍵。請反覆體悟三焦與六經的座標體系，這是臨床「立竿見影」的保證。

第三章 第三章：黃帝內針的基本特點

3.1 第一節：執兩用中

- 主要概念與理論：
 - 核心奧妙：源自《中庸》與《論語》，意即「執其兩端，用其中於民」。
 - 兩端與中：在針灸臨床中，「兩端」即是左與右、上與下、陰與陽。
 - 操作邏輯：當病症表現在「左（一端）」時，醫者必須在「右（另一端）」尋求平衡。只有符合左右、上下對應的原則，才能實現「中（陰陽自和）」的目的。
- 醫案示例要點：
 - 邏輯轉化：不論病症表現如何，只要能確定其在某一端，便在另一端施治。內針不追求繁複的補瀉手法，因為「中」的作用一旦被激發，人體會自動回歸天道的自然補瀉。
- 練習題核心考點：
 - 理解「執兩用中」是內針臨床選穴的大原則：以右治左、以左治右。

3.2 第二節：隨證治之

- 主要概念與理論：

- 證（症）為眼目：內針強調「隨證治之」，而非隨「病名」或「脈象」治之。
- 三位一體：所謂的「證」包含了病處（位）、病因與病治。它是機體對異常狀況的綜合表達。
- 醫案示例要點：
 - 定經與定位：臨床診斷的第一步是確定「證」在哪個經絡（如陽明經或少陽經），以及在哪個部位（如頭部或胸部）。只有「證」定準了，後續的取穴才有方向。
- 練習題核心考點：
 - 辨析「證」與「病」的區別。在內針體系中，症狀在哪經、哪位，即是治療的唯一指引。

3.3 第三節：同氣相求

- 主要概念與理論：
 - 法理之魂：這是內針取穴定位的最高準則。
 - 同氣的類別：
 1. 同名經同氣：例如手陽明與足陽明同氣。
 2. 同位同氣（三焦同氣）：上部（天部）與上部同氣，中部（人部）與中部同氣，下部（地部）與下部同氣。
 - 核心口訣：「穴可失，經可離，同氣不能丟」。
- 醫案示例要點：
 - 尋找同氣點：治病就是求同。若病在某一經、某一部位，施治的穴位必須在對應的同氣經絡與同氣部位上。若同氣不失，即便是偏離了標準穴位，也能見效。
- 練習題核心考點：
 - 同氣相求的層次：理解「同名經同氣」與「三焦同氣」如何交互運用。

3.4 第四節：導引

- 主要概念與理論：
 - － 醫患共振：導引是內針「五術」之一，其本質是通過「感」來實現機體陰陽的自利與自和。
 - － 身心貫通：針刺入後，醫者需「引」，患者需「感」。將患者的注意力從痛苦引向當下的變化，實現身心合一。
- 醫療實務規範：
 - － 留針時間：一般留針 45 分鐘。在此期間，患者應靜心留神，感受患處的細微變化。
- 練習題核心考點：
 - － 導引在五術中的地位及其實現代謝自利的深度意義。

3.5 第五節：神與形俱

- 主要概念與理論：
 - － 君火與相火：君火（心）以明，相火（心包、命門）以位。君火提供「明能」（智慧與光明），相火提供「熱能」（動能與變化）。
 - － 守神與守形：上等的用針是以「神」為依據（守神），下等是以「形」為依據（守形）。內針追求從守形上升到守神的境界。
 - － 阿是穴的真意：內針中的「阿是」即是**精確的定位**。它是為了確定相火系統的作用位置。
- 進階解說：
 - － 工在針外：內針的最高境界在於醫者的德行（大醫精誠）與對法理的把握。心法不可測，實則在於醫者的內修。
- 練習題核心考點：
 - － 理解「形」與「神」的關係，以及為什麼說「穴位的位定對與否，決定了相火效用的發揮」。

3.6 醫療實務的進階建議

醫療實務中，務必遵循以下原則：

1. **初級階段：**死守「同氣相求」與「左右治則」。不要糾結於複雜的病理，先看病在左還是在右，在哪一焦，屬哪一經。
2. **中級階段：**學會「導引」。不要把針紮進去就離開去喝茶。要與患者對話，引導他們去「找感覺」，這種醫患之間的能量流動是提升療效的秘訣。
3. **進階階段：**體悟「神與形俱」。意識到你手中的針不只是金屬，而是調整生命「相火」的工具。醫者的心定，針才靈。

（註：本章內容側重理論架構與思維模型，相關具體穴位對應表格將於第四章「總則」中詳細呈現。）

第四章 第四章：黃帝內針總則精要

4.1 第一節：方位治則（上病下治、下病上治、左病右治、右病左治）

- 主要概念與理論：

- 定格規範：左右治則是內針的「定之又定」，是不可違背的大原則。具體而言，**症在左，必須在右側下針**；症在右，則在左側下針。
- 陰陽對應：左為陽、右為陰，上為陽、下為陰。這種治則本質上是「陽病治陰，陰病治陽」，通過對端的調整實現氣血的「各守其鄉」。
- 進階心法：對於病症在身體中線的特殊情況，可採用「男左女右」原則，或根據患者自身的左右敏感度來確定施治側。

- 醫案示例要點：

- 若患者左側偏頭痛，即便對應的右側手部沒有明顯痛點，也必須在右側下針，這是定格。

- 練習題核心考點：

- 掌握「左右治則」的絕對性：在內針體系中，左側症狀應在何側取穴？（答案：右側）。

4.2 第二節：核心靈魂——同氣相求

- 主要概念與理論：

- 總則之首：同氣相求是內針取穴定位的最高原則，是方寸之間見神效的依據。
- 兩大維度：
 1. 經絡同氣：同名經（如手陽明與足陽明）氣相同，有求必應。
 2. 三焦（三才）同氣：上部（天部）對應上部，中部（人部）對應中部，下部（地部）對應下部。
- 核心口訣：「穴可失，經可離，同氣不能丟！」
- 三焦同氣的臨床定位表（軀幹）：

三焦層次	軀幹具體區域定位	肢體同氣部位對應
上焦（天）	前為鳩尾穴、後為至陽穴以上	腕關節、踝關節附近
中焦（人）	前為鳩尾穴至神闕穴、後為至陽穴至命門穴之間	肘關節、膝關節附近
下焦（地）	前為神闕穴、後為命門穴以下	肩關節、胯關節附近

- 六經三焦同氣對應表（核心 36 穴基準）：

— 註：以下為基準點，臨床應在該區域尋找最敏感的阿是穴。

經絡屬性	手部同氣（天/人/地）	足部同氣（天/人/地）
陽明經	陽溪 / 曲池 / 肩髃	解溪 / 足三里 / 髀關
少陽經	陽池 / 支溝 / 肩髃後	丘墟 / 陽陵泉 / 環跳
太陽經	陽谷 / 小海 / 肩貞	申脈 / 委中 / 承扶
太陰經	太淵 / 尺澤 / 中府（上三指）	商丘 / 陰陵泉 / 衝門
少陰經	神門 / 少海 / 極泉	照海 / 陰谷 / 長強旁 0.5 寸
厥陰經	大陵 / 曲澤 / 天池	中封 / 曲泉 / 陰廉

- 局部區域同氣對應表：

部位	經絡屬性	手部同氣穴位	足部同氣穴位
頭頂	厥陰經	勞宮	太衝
額面	陽明經	合谷	陷谷
側頭（耳）	少陽經	陽池、中渚	丘墟、足臨泣
後頭（頸項）	太陽/督脈	陽谷、後溪	申脈、束骨
咽喉/任脈	任脈	列缺	照海

- 醫案示例要點：

- 腰痛（正中）：病在中焦、太陽經。取對側足部人部（委中）或手部人部（小海）。
- 腹痛（胃脘）：病在中焦、陽明經。若標準足三里效果不佳，應檢查是否涉及太陰，配合陰陵泉。

- 練習題核心考點：

- 如何精確界定軀幹中焦的範圍？（答案：鳩尾穴與神闕穴/命門穴之間）。
- 解釋「穴外定穴」的邏輯：利用「同身寸兩分法」在同氣經絡上等比例尋找敏感點。

4.3 第三節：變通之道——陰陽倒換求

- 主要概念與理論：

- 安全性與便利性：內針嚴格限制在肘膝以下。當病灶在肩、胯等「地部（下焦）」時，直接對應地部不便施針，此時可利用陰陽倒換。
- 倒換邏輯：下焦（地部）的問題，可以倒換到手足的天部（腕踝）來解決。這既是「下病上取」，也是利用三焦層次的相對性。

- 醫案示例要點：

- 肩周炎（陽明經）：病在肩（地部），本應對應地部，但為安全起見，倒換至腕部的陽溪或踝部的解溪。若以此為「天」，則二穴不就在地部了嗎？這便是陰陽倒換的智慧。

- 練習題核心考點：

- 陰陽倒換求的主要目的是什麼？（答案：為了解決肘膝以上不便針刺的問題，確保醫療安全與操作便利）。

4.4 寄語：醫療實務的原則

實踐中，務必養成「三二一」的思維習慣：

1. 三（定位）：先看病在天、人、地哪一焦。
2. 二（辨經）：辨明病在六經的哪一經。
3. 一（找阿是）：在對應的同氣經絡與部位，尋找最敏感的阿是穴進針。

切記：能用一針解決的問題，絕不用兩針。醫道至簡，只要守住「同氣」這個魂，臨床便能應手而效。

第五章 第五章：黃帝內針用針規範

5.1 第一節：「三二一」規範

- 主要概念與理論：

- **法理邏輯**：內針的用針規範遵循《老子》「道生一，一生二，二生三，三生萬物」的逆向推導，即從「三」退回到「一」。
- 「三」：**定位三焦**。無論何處不適，首要任務是確定其在「三部（三才）」中的位置——是屬於上（天）、中（人）還是下（地）。例如，頭痛位於天部，則取穴必須在對應的天部區域（腕踝末端）。
- 「二」：**辨經陰陽**。在確定三焦後，需進一步辨明病處屬於六經（三陰三陽）中的哪一經，並根據「左病右治、右病左治」確定施治側。如前額痛屬陽明經，側頭痛屬少陽經。
- 「一」：**尋找阿是穴**。這是最精確的下針定位。內針的「阿是」建立在同氣的基礎上。

- 醫案示例要點：

- 以右側額頭痛為例：
 1. 三：額頭屬上焦（天部）。
 2. 二：右側病取左側；額頭屬陽明經。
 3. 一：在左手合谷穴（陽明經天部基準點）及周邊區域，用拇指按壓尋找最酸、麻、脹、痛的點作為阿是穴進針。

- 練習題核心考點：

- 內針阿是穴與傳統阿是穴的區別：傳統阿是穴多在患處，內針阿是穴則是在確定的同氣區域中尋找最敏感的壓痛點。

5.2 第二節：穴外定穴

- 主要概念與理論：

- 超越標準經穴：人體的病變不一定剛好發生在標準穴位上。當症狀出現在兩穴之間時，取穴也應隨之變動。
- 同身寸兩分法：這是內針處理「非標準位」病症的核心技術。如果病症出現在陽溪穴與曲池穴連線的中點，那麼對應的同氣點也應在對側解溪穴與足三里穴連線的中點。
- 不離同氣：無論病在何處，只要能找到對應比例的同氣點，就能實現「八九不離十」的療效。

- 醫案示例要點：

- 若病症位於經絡的四分之一處或三分之一處，醫者應在同氣經絡上以同樣比例定穴，此處即為「同氣」的延伸應用。

- 練習題核心考點：

- 理解《素問·陰陽離合論》中「數之可十，推之可百……然其要一也」在定位上的意義：萬變不離同氣。

5.3 總結：醫療實務的應用原則

臨床實務，務必遵循以下三點建議：

1. 規範化操作：內針不求針感（得氣），不計補瀉，不需提插捻轉。你們的精力應全部集中在「三二一」的推導上，定位的精準度直接決定了療效。
2. 臨床靈活性：雖然有基準穴位，但不要被穴位圖框死。學會使用「阿是之法」在同氣區尋找那個最具「神機」的點。

3. 遵循安全邊界：會詳述，但在此預告，除了急救，內針的用針範圍嚴格限制在肘膝以下，軀幹及頭部禁針。這既是法理的要求，也是保護職業生涯的安全底線。

記住，「穴可失，經可離，同氣不能丟」。

第六章 第六章：黃帝內針用針注意事項

6.1 一、主要概念與理論

6.2 第一節：進針方法及特點

- 主要概念與理論：
 - － 技術特色：黃帝內針的進針法不追求傳統針刺的「提插捻轉」與「行針補瀉」。
 - － 操作要領：以拇指、食指、中指輕捏針柄，一般採取 45 度角傾斜刺入。
 - － 靈活應用：醫者可根據刺針部位的肌肉厚度與解剖特徵，靈活選擇直刺、平刺、深刺或淺刺。
- 初級至進階解說：
 - － 初級：初學者最常見的錯誤是糾結於「得氣」（酸麻脹痛感）。在內針法理中，療效源於「同氣相求」的精確座標，而非針感。
 - － 進階：進階者應體會針下的「神機」。不提插不代表無作為，而是透過靜心的持針，讓針具成為引導陰陽自和的媒介。

6.3 第二節：用針禁忌

這是內針醫師必須刻在腦子裡的「五條鐵律」：

1. 禁針區域：肘、膝關節以上，以及整個軀幹及頭部禁針（除非急救例外）。
2. 禁針部位：患處（病灶處）禁針。症狀在哪裡，針就絕對不紮在哪裡。
3. 特定人群：不留宿者或無法密切觀察的患者慎用（不宿者禁針）。
4. 特殊狀態：患者處於極度疲勞、過飢、過飽、大汗、大泄、大失血或飲酒後，不宜用針。
5. 皮膚狀況：皮膚受損、潰瘍或發炎區域禁針。

6.4 第三節：暈針等的處理及預防

- 主要概念與理論：

- 暈針定義：指在針刺或留針過程中，患者發生的突然昏厥現象。多見於初診緊張、體質虛弱或操作不當者。
- 臨床表現：頭暈目眩、面色蒼白、心慌氣短、冷汗直流、惡心欲吐、脈微欲絕。

- 醫療實務處理（SOP）表格：

處理階段	具體操作規範
第一步：立即處置	停止針刺，將已刺之針迅速退出。
第二步：體位調整	引導患者平臥，頭部放低，足部抬高，鬆開衣帶，注意保暖。
第三步：給予溫飲	給予熱茶或溫開水飲之，通常可漸漸恢復。
第四步：穴位急救	若症狀較重，可選取以下精確穴位進行按壓或針刺：
核心急救穴位	水溝穴、素髎穴、內關穴、合谷穴、太衝穴、湧泉穴、足三里穴。
艾灸救逆穴位	百會穴、氣海穴、關元穴。
強力手法急救	提捏腋前大筋，或撥動極泉穴附近的大筋。

- 預防要點（醫師職責）：

1. **心理疏導**：對初診或緊張者做好解釋工作，消除疑慮。
2. **狀態確認**：詢問患者是否進食，避免飢餓狀態下針。
3. **專注操作**：醫者應思想集中，謹慎細心，密切觀察患者神態變化。

6.5 二、醫療實務示例要點（臨床情境模擬）

假設一名患者在留針 15 分鐘後，突然主訴「胸口悶、想吐」，且臉色轉青。
作為內針醫師，你應遵循：

1. **果斷撤針**：不要猶豫，立刻起出所有在手的針。
2. **環境管理**：讓圍觀者散開，確保空氣流通。
3. **指代針法**：若情況緊急且不便再度用針，立即掐按其**水溝穴（人中）**與**合谷穴**，並按照附錄所述，強力撥動其腋下**極泉穴**區域的大筋以激發心經經氣。

6.6 三、練習題核心考點

1. **內針的安全界限**：在非急救情況下，黃帝內針絕對不能針刺哪些部位？（答案：肘膝以上、軀幹、頭部）。
2. **暈針首選處理**：當患者暈針時，醫師第一時間該做的動作是什麼？（答案：立即起針）。
3. **急救穴位辨識**：請寫出三個用於救治重症暈針的常用穴位名稱。（答案：水溝穴、內關穴、湧泉穴）。

6.7 總結

第六章是黃帝內針的「護身符」。內針雖然追求「立竿見影」的療效，但那是建立在「不傷正氣」與「技術安全」的前提下。行醫過程中，務必尊重這些禁忌與規範，這才是成為一名「明理」大醫的基石。

下编：各论

各論是將理論轉化為臨床實戰的具體指引。請記住，在內針的視野中，「症狀在哪裡，治療的座標就在哪裡」。

第七章 下篇：各論概述

7.1 一、主要概念與理論：內針操作的核心算法

在進入各論實踐時，必須嚴格遵循「三、二、一」規範，這是內針取穴的最高準則：

1.「三」：明確經絡與空間座標

- 三焦定位：首先判斷症狀是在上、中、下三焦的哪一部？
- 辨經定位：在對應的三焦中，症狀涉及三陰三陽的哪一條或哪幾條經絡？

2.「二」：明確方位與治則

- 定格左右：明確是「左病右治」還是「右病左治」。
- 定格上下：明確是「上病下治」還是「下病上治」。
- 特殊情況：若病在中間或兩側症狀相似，則依「男左女右」取穴。

3.「一」：尋找「阿是穴」

- 同氣求點：在上述確定的三焦、經絡及對側區域內，尋找最敏感的「阿是穴」。
- 阿是為宗：內針的阿是穴是指**最敏感、最有感**（酸、麻、脹、痛）的那一個同氣點，它是治療的切入點。

7.2 二、臨床實務導引要點：心物合一的轉化

內針治療成功的關鍵在於「導引」，這要求在進針後立即與患者產生互動：

- **注意力轉向**：引導患者將注意力從原有的痛苦中移開，去**感受患處**「有沒有變化」。
- **動靜配合**：注意讓患者去體會病灶處的舒緩、清爽或活動度的增加，而不是停留在原本的症狀上。

7.3 三、療效提升的進階策略（強化方案）

若施針後效果不明顯，應具備以下三種進階應變能力：

1. **調針**：將針輕輕抽出一部分，或向上、下、左、右換個方向重新刺入，同時引導患者再次關注患處變化。
2. **補針**：重新對照法理，檢視辨經是否準確。若有遺漏，則重新選取對應經絡的同氣點進行補針。
3. **陰陽倒換**：這是內針最具特色的變法。若上述方法無效，可執行：
 - **上下倒換**：上病下取無效，改為上取（或反之）。
 - **前後倒換、表裏倒換**：靈活調整三焦層次的映射關係。

7.4 四、醫案示例要點（臨床流程總結）

概述中雖未列出具體病案，但為所有各論醫案定下了**標準流程**：

1. **診前定格**：先定三焦，再辨經絡。
2. **診中守形**：在同氣區域精確尋找阿是點。
3. **診後留針**：施針結束後，建議留針 **45 分鐘**左右。留針期間，要求患者靜靜地感受患處，嚴禁聊天、玩手機或分散注意力，以利陰陽自和。

7.5 五、練習題核心考點

1. **內針核心規範**：請默寫內針取穴的「三、二、一」規範具體內容。
2. **阿是穴定義**：在內針體系中，如果找不到最敏感的阿是穴，該如何處理？（答案：在相應同氣對應區域的穴位附近進針）。

3. **療效不顯的對策**：當第一針無效時，內針法脈建議的前三步應變措施是什麼？（答案：調針、補針、陰陽倒換）。
4. **留針規範**：內針一般留針時間為多久？留針期間對患者有何行為要求？（答案：45分鐘；要求靜靜感受患處，不建議聊天或看手機）。

7.6 叮嚀：醫療實務建議

概述雖然字數不多，但它是「操作指南」：

- 「不要停留於症狀」：病人在哭訴疼痛時，你的大腦要迅速將其轉化為「三焦、經絡、同氣」的座標。
- 「守住 45 分鐘」：很多時為了追求效率縮短留針時間，這是不對的。陰陽的調和需要時間，這 45 分鐘是給機體自我修復的寶貴視窗。
- 「防範暈針」：雖然概述中未詳述，但留針期間應隨時觀察患者神態，若出現不適應及時採取處理措施。

第八章 第一章：頭部

8.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）：

- 定位：頭部在三焦劃分中明確屬於上焦（天部）。
- 同氣部位：根據同氣相求原則，頭部的同氣點應在四肢的「天部」，即手（掌）部與足（掌）部。

2. 循行經絡（第二節）：

- 臨床必須能根據患者疼痛或不適的確切位置，迅速識別出對應的經絡：
 - － 巔頂（頭頂）：屬於足厥陰肝經與督脈的交會處。
 - － 側頭（耳部周邊）：主要由手、足少陽經循行。
 - － 前額及臉部：屬足陽明胃經循行區域。
 - － 後頭（枕部）：由足太陽膀胱經與督脈所主。

3. 針治法則（第三節）：

- 左右原則：左側頭部痛，取右側手/足同氣；右側痛，取左側。
- 中間與兩側：若痛在正中，按「男左女右」取穴；若兩側均痛，以症狀較重的一側為主證取穴。

8.2 二、核心同氣對應表格（根據總則彙整）

在治療頭部疾病時，必須參考以下同氣對應表進行取穴：

經絡屬性	頭部對應區域	手部同氣穴位 (上焦/天)	足部同氣穴位 (上焦/天)
厥陰經	頭頂（百會穴）	勞宮穴	太衝穴
陽明經	額頭、面部	合谷穴	陷谷穴
少陽經	側頭、耳部	陽池穴、中渚穴	丘墟穴、足臨泣穴
太陽經	後頭、腦後區域	陽谷穴、後溪穴	申脈穴、束骨穴
督脈	巔頂、後頭正中	後溪穴	申脈穴

(註：以上穴位點均為區域基準，臨床應在該穴附近尋找最敏感的阿是點)

8.3 三、醫案示例要點（臨床思維推導）

1. 左側頭部疼痛（少陽證）：

- 辨證：三焦定位為上焦；經絡辨證為少陽經。
- 治則：左病右治，取右手。
- 選穴：在右手少陽經的**中渚穴**附近尋找阿是穴進針。

2. 頭頂及右側昏脹（厥陰、少陽證）：

- 辨證：巔頂屬厥陰，側部屬少陽。
- 治則：病在右側，取左側。
- 選穴：在左足厥陰經**太衝穴**及少陽經**足臨泣穴**附近各刺一針。

3. 頭部後側正中昏沉（太陽、督脈證）：

- 辨證：病在後側正中，涉及太陽與督脈。
- 治則：病位在正中，若患者為男性，取左手施治。
- 選穴：在左手太陽經及督脈交會的**後溪穴**附近進針。

8.4 四、練習題核心考點

- 考題情境：一位 66 歲男性，主訴前額及頭部兩側、枕部均有明顯脹痛，以前額最為嚴重。

- 解題邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：頭部為上焦，取穴範圍在肘膝以下的腕踝區域。
 2. 二（辨經）：前額為陽明經，兩側為少陽經。因患者為男性，病在中間或兩側，首選左側。
 3. 一（定穴）：應在左手陽明經合谷穴及少陽經中渚穴（或左足對應穴位）尋找阿是點進針。

8.5 導讀：醫療實務建議

處理頭部，務必遵循以下實務原則：

- 導引的配合：內針不僅是紮針，更是「導引」。進針後，應立即引導患者感受患處的變化，讓他們的注意力從痛苦中抽離，這對消除頭部脹痛有奇效。
- 辨經的精確度：頭痛不能「一概而論」。前額、巔頂、側頭的經絡完全不同。如果選錯了經絡（同氣不合），療效會大打折扣。
- 不宿者禁針：臨床實務中，對於無法在施治後留在當地觀察的患者（不宿者），應慎用針刺。

第九章 第二章：眼部

眼部問題在臨床上非常多見，從常見的乾澀癢到較為嚴重的底出血、視力模糊，黃帝內針都能提供一套極具邏輯性的治療方案。必須明白：眼部雖小，卻是五臟六腑精氣上注之所，經絡巡行極其複雜。掌握這一章，能極大地鍛煉你們「細化辨經」的功力。

9.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）：

- 定位：眼部位於頭面部，明確屬於上焦（天部）。
- 同氣部位：根據同氣相求原則，其同氣點對應於四肢的「天部」，即手（掌）部與足（掌）部。

2. 循行經絡（第二節）：

- 眼部是多條經脈的匯聚點，進針前必須精確辨經：
 - － 手少陰心經：其支脈「連目系」。
 - － 足厥陰肝經：其脈「連目系，上出額」。
 - － 手太陽小腸經：其支脈「別頰上頤抵鼻，至目內眦，斜絡於顴」。
 - － 足太陽膀胱經：起於「目內眦」，上額。
 - － 足陽明胃經：起於「鼻之交頤中，旁納太陽之脈，下循鼻外」。
 - － 手少陽三焦經：支脈「至目銳眦」。

3. 常用經絡同氣對應表（眼部專項彙整）：

經絡屬性	眼部對應區域	手部同氣穴位 (上焦/天)	足部同氣穴位 (上焦/天)
陽明經	目內眥、鼻根側、 下眼瞼	合谷穴	陷谷穴
少陽經	目銳眥（外眼角）	中渚穴、陽池穴	足臨泣穴、丘墟穴
太陽經	目內眥、上眼瞼	後溪穴、陽谷穴	束骨穴、申脈穴
少陰經	目系、目內側	少府穴、神門穴	照海穴、太溪穴
厥陰經	目系、眼球深處	勞宮穴、大陵穴	太衝穴、中封穴

9.2 二、針治法則（第三節）

- 左右原則：左眼症狀取右側；右眼症狀取左側。
- 兩側原則：
 - － 症狀相似者，按「男左女右」取同氣。
 - － 症狀程度不同者，以「嚴重一側」作為主證取對側同氣。

9.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 眨眼異常（陽明證）：

- 要領：眼瞼（胞輪）多屬脾胃。取對側合谷穴附近阿是點。
- 進階思考：若效果不明顯，可考慮肝、心經絡（太衝穴、少府穴），因「肝開竅於目」，心主目系。

2. 眼睛乾癢（少陰、厥陰、陽明證）：

- 要領：涉及多經時應合治。取對側少府穴（少陰）、勞宮穴（厥陰）、合谷穴（陽明）附近各刺一針。

3. 左眼眼瞼腫痛（陽明、少陽證）：

- 要領：左病右治。取右側合谷穴（陽明）、中渚穴（少陽）附近。

- **進階思考：**若首診後症狀加重，需重新審視是否辨經有誤或需調整阿是穴的精確度。

4. 右眼底出血致視力模糊（多經合治）：

- **要領：**重症需全盤考慮。取左側少府穴、勞宮穴、後溪穴、合谷穴、中渚穴附近各一針，全面調和五臟六腑注於目之精氣。

9.4 四、練習題核心考點（第五節）

- **考題情境：**一位 27 歲男性，自述眼皮沈重，眼球內眥處有血絲，前額中間至鼻樑處酸脹。
- **解題邏輯（三二一規範）：**
 1. 三（定位）：眼部與前額均屬上焦（天部）。
 2. 二（辨經）：內眥出血絲涉及太陽經與陽明經；前額至鼻樑屬陽明經與督脈。
 3. 一（定穴）：患者為男性，病在中間及兩側，首選左側。應在左手（或足）尋找後溪穴（太陽/督脈）、合谷穴（陽明）附近的同氣阿是點進針。

9.5 解說：醫療實務建議

眼部醫療實務，遵循以下專業建議：

- **辨經要「細」：**眼部的病位往往只差幾毫米，但對應的經絡卻大不相同。例如內眼角與外眼角的經絡歸屬完全不同，若辨經模糊，療效便如隔靴搔癢。
- **阿是穴要「精」：**在同氣區域（如合谷附近）按壓時，一定要找到患者最有感（酸、麻、痛）的那一點。對於眼部精細器官，阿是穴的精確度直接決定了氣血轉化的速度。
- **導引要「活」：**進針後，請務必引導患者閉目養神，感受眼部的熱感、清涼感或脹痛的消退。若患者能自發感受到眼部環境的變化，治療效果將更為持久。

- **進階視野：**當遇到疑難眼疾時，不要只盯着眼周看，要回頭看少陰與厥陰（心與肝）。內針雖然是在末端取穴，但其調整的是整體的陰陽中和。

第十章 第三章：耳部

耳部疾患在臨床上極其常見，從輕微的耳塞、耳鳴到嚴重的失聰，往往令患者感到十分困擾。在黃帝內針的體系中，處理耳部問題的邏輯非常清晰：只要抓準了上焦定位與少陽、陽明、太陽等經絡的交會關係，往往能取得令人驚訝的即時效果。

10.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）

- **理論核心：**耳部位於頭面側部，在三焦座標中明確劃分為**上焦（天部）**。
- **同氣部位：**根據「同氣相求」原則，耳部的同氣區域鎖定在四肢的末端，即**手（掌）部**與**足（掌）部**。

2. 循行經絡與交會（第二節）

- 耳部是多條陽經匯聚之地。必須能根據症狀出現的具體位置（耳內、耳前、耳後）來辨明經絡：
 - **手太陽小腸經：**由缺盆循頸上頰，至目銳眥，卻入耳中。
 - **足陽明胃經：**循頰車，上耳前。
 - **手少陽三焦經：**其支者從耳後入耳中，出走耳前。
 - **足少陽膽經：**其支者從耳後入耳中，出走耳前，至目銳眥後。

3. 常用經絡同氣對應基準（耳部專項）：

經絡屬性	耳部對應特徵	手部同氣穴位 (上焦/天)	足部同氣穴位 (上焦/天)
少陽經	耳部疾患之主軸	陽池穴、中渚穴	丘墟穴、足臨泣穴
陽明經	耳前、聽宮/聽會區域	合谷穴	陷谷穴
太陽經	耳中、耳廓後緣	後溪穴、陽谷穴	束骨穴、申脈穴

10.2 二、針治法則（第三節）

在醫療實務中，請嚴格遵守以下方位定格規則：

1. 左病右治：左耳不適，取右手（掌）或右足（掌）同氣。
2. 右病左治：右耳不適，取左手（掌）或左足（掌）同氣。
3. 中間或雙側：
 - 若症狀相似，按「男左女右」原則取同氣。
 - 若症狀輕重不等，以嚴重一側為主證，取其對側同氣。

10.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 左耳輕微耳塞（陽明、少陽證）：

- 症狀：左耳悶塞感。
- 辨證：病在左側，取右側。涉及耳前（陽明）與耳中（少陽）。
- 選穴：右手合谷穴（陽明）及中渚穴（少陽）附近尋找阿是點。
- 要領：進針後即刻請患者感受耳塞是否減輕。

2. 右耳失聰（太陽、陽明、少陽證）：

- 症狀：右耳聽力喪失。
- 辨證：病在右側，取左側。病程較重，需考慮多經合治。
- 選穴：左手後溪穴（太陽）、合谷穴（陽明）、中渚穴（少陽）附近阿是點各刺一針。

10.4 四、練習題核心考點（第五節）

- **考題情境：**一位 73 歲男性，主訴耳鳴，左耳尚有部分聽力，右耳基本失聰。
- **解題邏輯（三二一規範）：**
 1. **三（定位）：**耳部為上焦，目標區域在手足天部（腕踝關節附近）。
 2. **二（辨經）：**此為雙側耳疾，但**右耳顯著嚴重**。應以右側為主證，執行「右病左治」，取**左側**施針。
 3. **一（定穴）：**考慮耳部主經，應在左手（或左足）的少陽經（**中渚穴 / 足臨泣穴**）尋找最敏感的同氣阿是點。若合併耳鳴嗡嗡聲大，可加強陽明經（**合谷穴**）的處理。

10.5 導讀：醫療實務建議

在處理耳部疾病時，務必內化以下進階思維：

- **「少陽」是核心：**耳部疾病十之八九不離少陽。當你們在臨床上感到迷茫時，先從少陽經（手之**中渚**、足之**臨泣**）入手，往往能打開局面。
- **導引的即時性：**耳部神經敏感，進針後應立即請患者嘗試「鼓氣」或「按壓耳屏再放開」。這種物理性的導引配合針刺的氣血轉化，是提高療效的關鍵。
- **辨析「塞」與「鳴」：**耳塞多屬實證，陽明、少陽同治效果好；長期高頻耳鳴或失聰，除了少陽，務必檢查太陽經（**後溪 / 申脈**）的同氣點，因太陽主開，對改善聽力閉阻有助益。
- **堅持留針：**耳部疾患多具頑固性。臨床實務中建議留針滿 **45 分鐘**，給予機體充足的時間進行陰陽自和。

第十一章 第四章：鼻部

「肺開竅於鼻」，但在黃帝內針的臨床實務中，不只是從臟腑學說出發，更要從空間三焦與經絡循行的交織點來尋找答案。鼻部疾患如鼻塞、鼻出血、鼻炎等，是展現內針「同氣相求」神速療效的典型範例。

11.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）

- **定位：**鼻部位於頭面正中，在三焦座標中明確劃分為**上焦（天部）**。
- **同氣部位：**根據「同氣相求」原則，施治區域鎖定在四肢的末端，即**手（掌）部**與**足（掌）部**。

2. 循行經絡與交會（第二節）

- 鼻部是多條經脈的必經之地，尤其是陽經與督脈的關鍵節點：
 - **手陽明大腸經：**循行至人中，左之右，右之左，上挾鼻孔。
 - **足陽明胃經：**起於鼻，交頰中（鼻根）。
 - **督脈：**上系兩目之下中央，循額至鼻柱。
 - **手太陰肺經：**根據手（掌）頭同氣原理，拇指（背側）對應鼻部。

3. 鼻部循行經絡同氣基準表：

經絡屬性	鼻部對應區域	手部同氣穴位 (基準點)	足部同氣穴位 (基準點)
陽明經	鼻翼、鼻孔兩側	合谷穴	陷谷穴
督脈	鼻樑、鼻準正中	後溪穴	申脈穴
太陰經	鼻部整體（肺開竅於鼻）	魚際穴	太白穴
經外奇穴	鼻部疾患加強	大骨空穴	-

11.2 二、針治法則（第三節）

在臨床實務中，方位治則是確保「定格」精確的前提：

1. 左病右治：左側鼻孔不適（如出血、阻塞），取右手（掌）或右足（掌）同氣。
2. 右病左治：右側鼻孔不適，取左手（掌）或左足（掌）同氣。
3. 中間或雙側：
 - 若為鼻正中問題（如鼻準、鼻樑）或雙側鼻塞，按「男左女右」原則取同氣。
 - 若症狀程度不同，以嚴重一側為主證，取其對側。

11.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 鼻塞、流涕（督脈、陽明證）：
 - 要領：病在鼻部正中。男性取左側，女性取右側。
 - 選穴：手部督脈交會穴後溪穴、陽明經合谷穴附近尋找阿是點。
2. 左鼻孔出血（督脈、陽明證）：
 - 要領：左病右治。不論是出血還是阻塞，病位相同，取穴邏輯亦同。
 - 選穴：右側手部後溪穴、合谷穴附近各刺一針。
3. 慢性鼻炎（多經合治）：

- 要領：涉及鼻塞、呼吸不暢及額部昏沈。
- 選穴：除後溪穴、合谷穴外，加取太陰經魚際穴及經外奇穴大骨空穴，以加強肺經對鼻竅的調節力。

11.4 四、練習題核心考點（第五節）

- 考題情境：一位 30 歲男性，主訴嗅覺失靈（味覺不靈應為嗅覺）。
- 解題邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：鼻部為上焦（天部），施治於腕踝末端。
 2. 二（辨經）：鼻部為主證，涉及督脈與陽明經。患者為男性，取左側。
 3. 一（定穴）：在左手（或足）尋找後溪穴（督脈）與合谷穴（陽明）最敏感的同氣阿是點。

11.5 解說：醫療實務建議

處理鼻部問題時，遵循以下專業指引：

- 「異病同治」的實踐：在內針案例中，鼻塞與鼻出血的取穴完全相同。這告訴我們，內針治的是「位」與「氣」，只要座標（同氣點）對了，不論症狀性質如何，都能引導陰陽回歸中和。
- 督脈是鼻部的「脊梁」：許多學生只記得鼻部屬陽明，卻忽略了督脈行於鼻正中。臨床遇到鼻炎或鼻塞，後溪穴往往是打開局面的關鍵針。
- 導引的技巧：進針後，請務必請患者「用力吸氣、呼氣」，或按壓鼻翼。導引能使針下的氣機迅速灌注到鼻竅，實現「雪污、拔刺」般的即時效果。
- 注意經外奇穴的奇效：如大骨空穴（位於拇指背側指間關節中點）。因其位置與鼻部在「手（掌）頭同氣」中高度對應，對於頑固性鼻炎有顯著的輔助作用。

第十二章 第五章：脣口

脣口不僅是人體進食與發聲的門戶，更是觀察內臟氣血狀態的窗口。在中醫理論中，「脾開竅於口，其華在脣」，但在黃帝內針的實務中，必須運用更寬廣的六經辨證來處理潰瘍、腫痛與燥渴。對於初次接觸這門課的同學，請務必記住：口部雖小，卻是肝、脾、腎、胃等多條經脈交會之處。

12.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）

- 定位屬性：脣口部位於面部下端，在三焦座標中明確劃分為上焦（天部）。
- 同氣部位：根據「同氣相求」原則，脣口的對應施治區域鎖定在肢體末端的「天部」，即手（掌）部與足（掌）部。

2. 循行經絡與同氣（第二節）

- 脣口的病變往往涉及深層臟腑的氣機，需精確辨別受累經脈：
 - － 足太陰脾經：挾咽，連舌本，散舌下。
 - － 足少陰腎經：循喉嚨，挾舌本。
 - － 足厥陰肝經：從目系下頰裏，環脣內。
 - － 足陽明胃經：入上齒中，還出挾口環脣。

3. 脣口常用經絡同氣對應基準表：

- 註：本表彙整自手（掌）頭同氣原理，為臨床取穴之基準。

經絡屬性	脣口對應區域與功能	手部同氣穴位 (基準點)	足部同氣穴位 (基準點)
陽明經	脣口四周、齒齦	合谷穴	陷谷穴
太陰經	舌下、脾開竅之脣部	魚際穴	太白穴
少陰經	舌根、目系關聯	少府穴	照海穴
厥陰經	脣內、環脣部	勞宮穴	太衝穴
太陽經	頰面後部、齒部關聯	後溪穴	束骨穴

12.2 二、針治法則（第三節）

在實務操作中，方位定格是確保療效的「導航儀」：

1. 左病右治：左側脣口、牙齦或舌部不適，取右手（掌）或右足（掌）同氣。
2. 右病左治：右側症狀取左手（掌）或左足（掌）同氣。
3. 中間或雙側：
 - 若病位在正中（如舌尖、口脣正中）或症狀相似，按「男左女右」原則取穴。
 - 若症狀輕重不等，以嚴重一側為主證，取其對側同氣。

12.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 舌部潰瘍（太陰、少陰證）：
 - 醫案要點：65歲女性，舌尖及舌下潰瘍。
 - 辨證定位：三焦定位為上焦。涉及舌本（脾經/太陰）與舌根（腎經/少陰）。
 - 治則取穴：病在中間，女性取右側。選取右側魚際穴（太陰）與少府穴（少陰）附近阿是點。

2. 左下頷牙痛（太陽、陽明、厥陰證）：

- 醫案要點：41歲男性。
- 治則取穴：左病右治。涉及頷面（太陽）、齒齦（陽明）及環脣（厥陰）。
- 選穴：右側後溪穴（太陽）、合谷穴（陽明）、勞宮穴（厥陰）附近各刺一針。

3. 口渴不適（太陰、少陰、厥陰證）：

- 醫案要點：71歲男性。
- 治則取穴：病在口腔（中），男性取左側。
- 選穴：左手魚際穴、少府穴、勞宮穴附近阿是點。

12.4 四、練習題核心考點（第五節）

- 考題情境：一位 52 歲女性，主訴舌體及舌下口腔潰瘍，右下頷牙齦腫痛。
- 解題邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：脣口牙齦屬上焦（天部）。
 2. 二（辨經）：舌體涉及太陰、少陰；右下頷牙齦涉及陽明、太陽與厥陰。
 3. 一（定穴）：
 - － 針對舌部（中間）：女性首選右側，取魚際穴、少府穴。
 - － 針對右牙齦（右側）：執行「右病左治」，取左側之合谷穴、後溪穴、勞宮穴。

12.5 解說：醫療實務建議

處理脣口問題時，遵循以下專業指引：

- 辨經的綜合性：口部問題鮮少由單一經絡引起。例如牙痛往往伴隨脣部的腫脹，此時必須兼顧陽明與厥陰。在臨床上，「多經合治」是常態，不要怕針多，但每一針都要有明確的經絡依據。

- **「手（掌）頭同氣」的妙用：**在內針體系中，手掌中心區域對應頭面正中。因此，對於口舌生瘡，**勞宮穴**（厥陰）、**少府穴**（少陰）與**魚際穴**（太陰/肺）的微調往往能產生「清熱散結」的即時效果。
- **導引的細節：**下針後，請務必引導患者用舌尖輕觸潰瘍處，或嘗試做咀嚼與叩齒動作。導引能引導相火歸位，讓原本灼熱疼痛的患處迅速感受到清涼與舒緩。
- **進階思考——陰陽倒換：**若手掌部取穴效果不彰，可靈活倒換至足部的天部（**太衝、照海、陷谷、太白**等），法理相同，療效相通。

第十三章 第六章：面部

13.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）

- **定位屬性：**面部整體位於頭面部，在三焦座標中明確劃分為**上焦（天部）**。
- **同氣部位：**根據「同氣相求」原則，面部的施治區域應選取在肢體末端的「天部」，即**手（掌）部**與**足（掌）部**。

2. 循行經絡與交會（第二節）

- 面部是陽經最為集中的區域，幾乎涵蓋了所有的三陽經及督、任脈。進針前必須精確辨別症狀分佈的經絡：

經脈名稱	在面部之主要循行與交會特徵
手太陽小腸經	循頸上頰，至目銳眥，入耳中；其支者抵鼻，至目內眥。
足太陽膀胱經	起於目內眥，上額。
手陽明大腸經	挾鼻孔，左之右，右之左，上挾鼻孔。
足陽明胃經	起於鼻，交頰中，旁納太陽之脈，下循鼻外，入上齒中，還出挾口環唇，下交承漿，循頤後下廉，出大迎，循頰車。
手少陽三焦經	出走耳前，交頰，至目銳眥。

經脈名稱	在面部之主要循行與交會特徵
足少陽膽經	起於目銳眥，上抵頭角，下耳後；其支者下耳前，至目銳眥後。
督脈	循額至鼻柱。
任脈	會於咽喉，別而絡唇口。

13.2 二、針治法則（第三節）

在醫療實務中，請嚴格執行方位定格邏輯：

1. 左右治則：左側病，取右側手/足同氣；右側病，取左側。
2. 兩側或中間：
 - 若症狀相似或病位在正中，按「男左女右」原則取同氣。
 - 若症狀程度不同，以嚴重的側作為主證，取其對側施治。

13.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 痤瘡一例（陽明、太陽證）：
 - 要領：23歲女性，前額及面頰散見痤瘡。
 - 辨證：三焦定位為上焦。涉及陽明經（面頰）與太陽經（頰部/內眥）。
 - 方案：病在中間及兩側，女性取右側。選取右側手部後溪穴（太陽）、合谷穴（陽明）及三間穴（陽明）附近阿是點。
2. 面部雀斑一例（陽明、少陽證）：
 - 要領：50歲女性，顴骨及眼角外側雀斑。
 - 辨證：涉及陽明經（顴骨）與少陽經（目銳眥/眼角外側）。
 - 方案：取右側合谷穴（陽明）與中渚穴（少陽）附近阿是點。
3. 面癱後遺症一例（多經合治）：
 - 要領：33歲男性，右側臉頰僵硬麻木，口角歪斜。

- **辨證：**右病左治。涉及陽明經、少陽經、督脈與任脈。
- **方案：**取左側手部太陽經/督脈交會之後溪穴、陽明經合谷穴、三間穴、二間穴，及任脈同氣之列缺穴附近阿是點。

13.4 四、練習題核心考點（第五節）

- **考題情境：**一位 65 歲女性，主訴面癱後遺症，右眼不自主抽動，右側臉頰區域僵硬麻木。
- **解題邏輯（三二一規範）：**
 1. **三（定位）：**面部屬上焦（天部），取穴應在手足天部（腕踝關節區域）。
 2. **二（辨經）：**眼部抽動涉及太陽、少陽、陽明；臉頰麻木涉及陽明與少陽。執行「右病左治」，取左側施針。
 3. **一（定穴）：**在左手（或足）尋找後溪穴、合谷穴、中渚穴等基準穴位附近的同氣阿是點。

13.5 解說：醫療實務建議

處理面部問題時，遵循以下專業指引：

- **「面口合谷收」的深化：**在內針實務中，合谷穴不僅是一個穴位，它是陽明經天部的座標中心。對於面部問題，陽明經通常是「主戰場」，但必須配合後溪穴（太陽）或中渚穴（少陽）來補足其經絡覆蓋的盲區。
- **導引的神速效果：**特別是對於面癱或面部僵硬。進針後，應引導患者做「鼓氣」、「努嘴」、「眨眼」或「提頰」動作。這種「守形」的導引能使針下的氣機迅速調整面部相火系統的平衡，許多患者會在留針期間感受到「麻木感消退」或「肌肉變鬆」。
- **關於「阿是」的精準度：**面部神經豐富，患者對面部的感覺極其敏銳。你們在四肢末端尋找阿是點時，必須極其細心。當你按到那個患者感覺最酸、最痛的點時，這就是「同氣窗口」。

- **禁忌與安全：**切記，面部患處禁針。所有的治療必須在肘膝以下進行。這不僅是技術安全，更是為了讓「陰陽倒換」的法理能從末端有效地拉動整體的平衡。

第十四章 第七章：頸項

頸項部位於人體的頭部與軀幹之間，是氣血升降的樞紐，也是臨床上極為常見的發病區域（如頸椎病、落枕）。請記住一個核心邏輯：頸項的問題，我們絕不在頸項上下針，而是要透過「三焦定位」與「同氣相求」，在手足末端尋找平衡點。這不僅是為了安全，更是為了從源頭調適陰陽。

14.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）

- **空間屬性：**頸項部在三焦座標中明確劃分為上焦。
- **同氣部位：**基於「同氣相求」原則，上焦之病應在肢體的天部（末端）尋求對應。具體施治範圍定格在手（腕）部與足（踝）部。
- **進階導讀：**同學們在從事醫療實務時，看到頸部問題，大腦應立即反射出「手腕」與「足踝」這兩個操作窗口。

2. 循行經絡與交會（第二節）

- 頸項部是陽經匯聚之地。必須能根據病灶所在的具體「經絡區」來選取對應的穴位：
 - － 項後正中：由督脈所主。
 - － 項後兩旁：主要由足太陽膀胱經循行（如天柱、大杼區域）。
 - － 頸項側部：由手少陽三焦經與足少陽膽經所主（如風池、翳風區域）。
 - － 頸部前側與喉側：涉及足陽明胃經、手陽明大腸經。
 - － 前正中線：由任脈所主。

14.2 二、頸項經絡同氣對應表

在臨床取穴時，請務必遵循下表的對應關係（此表為內針臨床之核心）：

頸部經絡區	具體部位描述	手部同氣穴位 (基準點)	足部同氣穴位 (基準點)
督脈	頸項正中	後溪	申脈
太陽經	頸項兩旁（天柱、大杼區）	陽谷	崑崙
少陽經	頸側、風池、翳風、肩井	陽池	丘墟
任脈	咽喉（前正中）	列缺	照海
陽明經	喉部、大迎、水突等區域	陽溪	解溪

14.3 三、針治法則（第三節）

在實務操作中，請嚴格執行方位定格邏輯：

1. 左病右治：症在頸項左側，取右腕或右踝同氣。
2. 右病左治：症在頸項右側，取左腕或左踝同氣。
3. 兩側或中間：
 - 若症狀相似或病在正中（督脈/任脈），按「男左女右」原則取穴。
 - 若症狀程度不等，以嚴重一側為主證，取其對側施治。

14.4 四、醫案示例要點（第四節）

1. 落枕一例（太陽、少陽、督脈證）：

- 要領：49歲男性，左後側僵硬疼痛。左病右治，取右手腕。
- 選穴：在右手太陽經及督脈交會之後溪穴、少陽經陽池穴附近各刺一針。

- 導引：入針後，立即引導患者活動頸項，感受患處變化。
2. 頸項右側不適（陽明、少陽證）：
- 要領：25歲女性，右頸側及偏後僵硬。右病左治，取左側。
 - 選穴：左側陽溪穴（陽明）及陽池穴（少陽）附近。
3. 項後後側正中僵硬（太陽、督脈證）：
- 要領：58歲男性，病在正中。男左女右，取左側手腕。
 - 選穴：左手太陽經陽谷穴、督脈交會之後溪穴附近。

14.5 五、練習題核心考點（第五節）

- 考題情境：一位 47 歲女性，主訴頸項後側正中向兩側延伸疼痛，左側轉頭受限顯著。
- 解題邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：頸項部為上焦（天部），選穴於手腕或足踝。
 2. 二（辨經）：正中涉及督脈（取後溪），向兩側延伸涉及太陽經（取陽谷）。因左側嚴重，執行「左病右治」，選右側施針。
 3. 一（定穴）：在右側手部尋找後溪穴、陽谷穴最敏感的同氣阿是點。

14.6 解說：醫療實務建議

處理頸項問題時，遵循以下專業指引：

- 「導引」是靈魂：頸項病變多涉及肌肉與關節的活動。下針後，請務必請患者「當場轉頭、低頭、仰頭」。導引能使針下的氣機迅速「解結」，這也是檢驗同氣點選取是否精確的標準。
- 安全邊界的守護：頸部有許多神經與血管，傳統針灸風險較高。內針法脈規定「肘膝以上禁針」，將治療點放在手腕與足踝，這是對醫師與患者最大的保護。
- 關於「阿是」的精細化：內針的阿是穴是指在「同氣區域」內最敏感的點。當你在後溪或陽池附近按壓時，一定要找到患者最有感的那一點。

- **綜合思維：**若頸項疼痛涉及肩部，應參考第四章的總則，靈活運用「三焦定位」與「六經辨證」進行多經合治。

第十五章 第八章：咽喉

咽喉是人體呼吸與飲食的共同門戶，巡行經絡極其密集，因此在臨床上，咽喉病症往往是多經交織的結果。這門課是學習**精準辨經**的絕佳實踐；是體會內針如何處理「狹小空間內複雜氣機」的關鍵章節。在醫療實務中，務必守住「上焦」定位，並靈活運用導引，以實現咽喉的清潤與中和。

15.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（空間座標）：

- **定位：**咽喉部位於人體最上端，在三焦劃分中明確屬於**上焦（天部）**。
- **對應區域：**根據同氣相求原則，其同氣點對應於四肢末端的「**手部**」，即**手（腕）部**與**足（踝）部**。

2. 循行經絡（辨證路徑）：

- 咽喉是經脈巡行最密集的區域之一，必須熟記以下六條核心路徑以利辨證：
 - － **足太陰脾經：**挾咽，連舌本。
 - － **手少陰心經：**上挾咽，系目系。
 - － **足少陰腎經：**循喉嚨，挾舌本。
 - － **足厥陰肝經：**循喉嚨之後，上入顙顙。
 - － **足陽明胃經：**循喉嚨，入缺盆。
 - － **任脈：**循腹裏，上關元，至咽喉。

15.2 二、咽喉經絡同氣對應表

根據講義所述，咽喉的取穴思路可參考「頸項經絡」的同氣規則，並結合任脈、陰經的特性進行擴展：

經脈名稱	咽喉對應特徵	手部同氣穴位 (基準點)	足部同氣穴位 (基準點)
任脈	咽喉正中、異物感、嘶啞	列缺穴	照海穴
陽明經	喉嚨兩側、咽下不適	陽溪穴	解溪穴
少陰經	喉嚨深處疼痛、乾嘔	神門穴	太溪穴
厥陰經	咽部緊縮、梅核氣	大陵穴	中封穴
太陰經	咽癢、乾咳、與脾關聯	太淵穴	商丘穴

15.3 三、醫案示例要點

在臨床實務中，咽喉病症常需多經合治以提高療效：

- 咽喉異物感（梅核氣）：55 歲女性。辨證涉及陽明經、少陰經與任脈。取對側手部（或按男女規律）之陽溪穴、神門穴、列缺穴附近各刺一針，效果顯著。
- 咽喉腫痛：25 歲男性。涉及少陰、厥陰、陽明、任脈。取穴神門穴、大陵穴、陽溪穴、列缺穴附近的阿是點。
- 咽癢、乾咳：48 歲女性。此例特點在於加入了太陰經（肺）的調治。取太淵穴、神門穴、大陵穴、陽溪穴、列缺穴。

15.4 四、練習題核心考點

- 練習題場景：64 歲男性，主訴聲音嘶啞，說話困難。
- 解題核心（三二一規範）：
 1. 三（定位）：咽喉屬上焦，目標區域在手足天部（腕踝關節區域）。
 2. 二（辨經）：失音主要與少陰、太陰及任脈密切相關。患者為男性，取穴以左側為主。
 3. 一（找點）：在左手（或左足）尋找神門穴（少陰）、太淵穴（太陰）與列缺穴（任脈）附近的阿是點進針。

15.5 叮嚀：醫療實務建議

處理咽喉疾患時，務必內化以下實務準則：

1. 「列缺」是咽喉的守護神：講義多次提到列缺穴通任脈，對於咽喉正中的不適感，不論是腫痛還是異物感，列缺往往是打開局面的首選。
2. 導引的絕對重要性：進針後，請務必請患者立即進行「吞嚥動作」或嘗試發聲。這種導引能將針刺引發的氣血流轉直接作用於病灶處，是實現「立竿見影」的關鍵環節。
3. 多經合治的辨證精度：雖然咽喉經脈眾多，但不代表要滿手紮針。你們應觀察患者疼痛偏向何處。若偏向氣管或舌根，則側重少陰、太陰；若偏向食道或兩側肌肉，則加強陽明、厥陰。
4. 大道至簡：內針的核心在於「中和」。在四肢末端取穴，既保證了安全，又避免了對患處的二次刺激。請始終牢記「穴可失，經可離，同氣不能丟」的法旨。

第十六章 第九章：肩部

肩部的經絡分布極其複雜，涉及三陽經、三陰經以及督脈。對於大學生來說，這一章是磨練「**細化辨經**」能力的關鍵。在黃帝內針的視野下，肩部雖然解剖結構複雜，但只要掌握了「**上焦定位**」與「**倒換智慧**」，處理起來就能游刃有餘。

16.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）：

- **空間屬性**：肩部及其背部的延伸區域（膈俞穴以上），在三焦劃分中明確屬於**上焦**。
- **同氣部位**：基於「上病下治、同氣相求」原則，肩部的同氣點應在肢體的天部（末端），即**手（腕）部**與**足（踝）部**。

2. 循行經絡（第二節）：

- 肩部是多條經脈的交匯樞紐，醫師進針前必須判斷受累的確切「**經絡區域**」：
 - － **肩前大筋區域**：多屬**手太陰肺經**。
 - － **肩胛、天宗穴周邊**：由**手、足太陽經**及**督脈**（大椎附近）所主。
 - － **肩峰、肩髃穴區域**：由**手、足陽明經**與**少陽經**所主。
 - － **肩腋深處與內側**：涉及**手少陰心經**與**手厥陰心包經**。

16.2 二、肩部經絡同氣對應基準表

在醫療實務中，醫師應根據病灶所在的經絡區域，於對側（或按男女規律）的同氣區域尋找阿是點：

經絡屬性	肩部病灶對應區域	手部同氣穴位 (基準點)	足部同氣穴位 (基準點)
太陽經/督脈	肩胛、天宗、大椎、背後緣	後溪穴、陽谷穴	申脈穴、崑崙穴
陽明經	肩前緣、肩髃穴前、二間/三間區	合谷穴、陽溪穴	陷谷穴、解溪穴
少陽經	肩峰、肩髃穴後、肩井區域	陽池穴、中渚穴	丘墟穴、足臨泣穴
太陰經	肩前大筋、舉臂受限前緣	魚際穴、太淵穴	太白穴、商丘穴
厥陰經	肩腋內側、功能障礙	勞宮穴、大陵穴	太衝穴、中封穴
少陰經	肩腋深處、心臟病牽引不適	少府穴、神門穴	照海穴、太溪穴

16.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 左側肩部疼痛（陽明、少陽證）：

- 辨證：26 歲男性，病在左側，定位上焦。涉及肩峰陽明、少陽經。
- 治則：左病右治，取右手。
- 選穴：在右手陽明經（陽溪穴附近）與少陽經（陽池穴附近）尋找阿是點進針。

2. 背部疼痛（太陽、督脈證）：

- 辨證：33 歲女性，大椎及右肩胛內側痛。病在右，取左。涉及太陽經與督脈。
- 選穴：取左手太陽經後溪穴附近阿是點，此處亦為督脈交會。

3. 肩膀抬舉不利（太陰、太陽、陽明證）：

- 辨證：50 歲男性，左側肩膀抬舉受限，痛在上方及後側。
- 選穴：右側手部魚際穴（太陰）、後溪穴（太陽）、合谷穴（陽明）附近阿是點。

4. 肩膀後展困難（太陰、厥陰證）：

- 辨證：52 歲女性，右肩後展困難，病在右，取左。涉及肩前（太陰）與內側（厥陰）。
- 選穴：左手太陰經魚際穴、厥陰經大陵穴附近。

16.4 四、練習題核心考點（第五節）

- 練習題場景：76 歲女性，左肩關節前側、後側、外側均疼痛，伴隨抬舉及後展不利。
- 解題核心邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：肩部為上焦，取穴定格在對側手腕或足踝關節區域。
 2. 二（辨經）：前側涉及太陰，後側涉及太陽，外側涉及陽明/少陽。執行「左病右治」，選右側施針。
 3. 一（找點）：在右手（或右足）尋找魚際穴、後溪穴、合谷穴、陽池穴等基準穴位附近的同氣阿是點。

16.5 解說：醫療實務建議

處理肩部問題時，遵循以下專業指引：

- 「導引」的當場驗證：肩部是功能性最強的關節。進針後，務必請患者「當場做原本做不到的動作」（如抬手、梳頭、摸背）。如果動作改善不明顯，說明你選的同氣點（阿是穴）不夠精準，需立即調針或重新定位。
- 陰陽倒換的智慧：雖然肩部在軀幹大三焦中屬上焦，但在四肢小三焦中，肩膀其實對應「地部」（下焦）。當你在天部（腕踝）取穴無效時，可以思考陰陽倒換，利用三焦層次的相對性來尋求突破。

- **禁針底線：**除非急救，肩部患處絕對禁針。我們是在四肢末端透過「同氣」來撥動氣機，進而讓肩部的「相火」歸位。
- **多經合治的果斷性：**肩部問題很少單一經絡受累。臨床上不要吝嗇多刺一兩經的同氣點，只要辨經準確，每一針都在為陰陽的中和做貢獻。

第十七章 第十章：腰部

腰痛的辨證往往容易與腎虛混淆。但在內針的邏輯中，我們更專注於空間三焦的定位與六經巡行的對應。腰部是人體轉旋的樞紐，也是多條關鍵經脈（如督脈、帶脈、太陽經等）的交匯點。掌握這一章，能讓你們在處理各類腰椎問題時，建立起一套精準的座標系統。

17.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位與同氣（第一節）

- **定位屬性：**腰部在人體軀幹中屬於中焦（人部）。
- **同氣部位：**根據「同位同氣」原則，中焦之病應對應四肢的「人部」，即肘關節與膝關節區域。
- **進階思維：**雖然腰部定位在中焦，但臨床上若涉及尾椎或腰骶部，則可能下移至下焦範圍，應根據疼痛的確切位置靈活判斷。

2. 循行經絡與辨證（第二節）

- 腰部病變的經絡歸屬是取穴成敗的關鍵：
 - － 項後及腰背正中：由督脈所主，與腎脈及太陽經密切相關。
 - － 脊柱兩側（夾脊）：主要由足太陽膀胱經循行。
 - － 腰部側緣及向腹部延伸：涉及足陽明胃經。
 - － 環繞腰部一週：屬於帶脈的範疇。
 - － 深層酸痛或涉及生殖泌尿：常涉及足少陰腎經。

17.2 二、腰部經絡同氣對應基準表

根據內針總則與本章醫案彙整，腰部各區域對應的取穴基準如下：

腰部經絡區域	臨床特徵描述	手部同氣穴位 (肘部/人)	足部同氣穴位 (膝部/人)
太陽經 / 督脈	脊柱兩側疼痛、 腰背僵硬	小海穴	委中穴
帶脈 / 少陽經	腰側部疼痛、環 腰一週感	支溝穴、外關穴	陽陵泉穴、足臨 泣穴
少陰經	腰部深處酸痛、 不能俯仰	少海穴	陰谷穴
陽明經	腰痛向前腹部放 射	曲池穴	足三里穴

17.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 左側腰背部酸痛（太陽經、帶脈證）：

- 要領：47歲男性，左病右治，取右手肘部。
- 辨證：涉及太陽經（脊旁）與帶脈（環腰）。
- 選穴：右側手太陽經小海穴、帶脈交會之外關穴附近各刺一針。

2. 腰椎正中疼痛（太陽經、少陰經證）：

- 要領：72歲女性，病在正中，不能俯仰。按女右取穴，取右肘/膝。
- 辨證：正中涉及督脈與太陽經；不能俯仰多與少陰腎經有關。
- 選穴：右側手太陽經小海穴、足少陰經陰谷穴附近的阿是點。

3. 腰部雙側酸痛（多經合治）：

- 要領：63歲女性，腰部雙側均痛。以重側為主或按女右取右側。
- 辨證：涉及少陰經、太陽經、陽明經與帶脈。
- 選穴：右側手部少海穴（少陰）、小海穴（太陽）、曲池穴（陽明）、外關穴（帶脈）附近各刺一針。

17.4 四、練習題核心考點（第五節）

- **考題情境：**一位 35 歲男性，腰背部左側及左後側散見紅斑，且有明顯癢痛感。
- **解題邏輯（三二一規範）：**
 1. **三（定位）：**腰背部為**中焦（人部）**，取穴範圍定格在對側肘部或膝部區域。
 2. **二（辨經）：**左側及左後側主要涉及**太陽經與少陽/帶脈**。執行「左病右治」，取**右側**。
 3. **一（找點）：**在右側肘部尋找**小海穴（太陽）、支溝穴或外關穴（少陽/帶脈）**附近的同氣阿是點進針。

17.5 解說：醫療實務建議

腰部治療在內針臨床中占有極大比例。要「立竿見影」的效果，務必遵循以下原則：

1. **「帶脈」不可忽略：**臨床上許多腰痛患者描述「像被繩子勒住」或疼痛橫向發展，這多屬帶脈病。此時必須加取**外關穴（通陽維脈/帶脈相關）**或**支溝穴**，單取太陽經效果往往受限。
2. **導引的動態驗證：**腰部是負責活動的。進針後，請務必引導患者做「**前俯後仰、左右轉側**」。如果患者說「轉身變輕鬆了」，說明你選的同氣點精確無誤；若改善不明顯，請立即重新辨經或調針。
3. **少陰經與慢性腰痛：**對於長年的慢性腰痛或腰部無力，除了表層的太陽經，務必檢查**少海穴（心/少陰）**或**陰谷穴（腎/少陰）**的同氣點。少陰主骨，是治療深層腰疾的根基。
4. **守住肘膝規範：**腰部雖痛，絕對禁針。所有的調整都必須在**肘、膝關節**附近完成。這既是內針的安全底線，也是發揮「同氣相求」法力的唯一窗口。

第十八章 第十一章：胸部

胸部在傳統中醫中是「宗氣」匯聚之所，也是心肺所在的門戶。這一章不僅是學習針灸，更是學習如何透過三焦座標與經絡巡行來處理如胸悶、乳房脹痛、咳嗽等常見疾患。在黃帝內針的視野中，胸部的治療點絕對不在胸部，而是在肘膝以下的同氣區域。

18.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（第一節）

- **定位屬性：**胸部整體在三焦座標中明確劃分為上焦（天部）。
- **同氣部位：**根據「同氣相求」原則，上焦之病應對應四肢的天部（末端），即手（腕）部與足（踝）部。
- **初級點撥：**當病人在胸部感到不適時，你們的操作範圍應定格在腕關節或踝關節附近。

2. 循行經絡（第二節）

- 胸部巡行經絡極其密集，辨經的精確度決定了療效的「立竿見影」：

經脈名稱	循行胸部之特徵描述
足太陰脾經	入腹，屬脾，絡胃，上膈，挾咽。
足少陰腎經	上貫肝、膈，入肺中，循喉嚨。
足厥陰肝經	挾胃，屬肝，絡膽，上貫膈，布脅肋，循喉嚨之後。

經脈名稱	循行胸部之特徵描述
足陽明胃經	循喉嚨，入缺盆，下膈，屬胃，絡脾；其直者，從缺盆下乳內廉。
足少陽膽經	下頸、合缺盆，以下胸中，貫膈，絡肝，屬膽，循脅里；其直者，從缺盆下腋，循胸過季脅。
任脈	循腹里，上關元，至咽喉。

18.2 二、針治法則（第三節）

在臨床實務中，請嚴格執行方位定格邏輯：

1. 左病右治：症在胸部左側，取右腕或右踝同氣。
2. 右病左治：症在胸部右側，取左腕或左踝同氣。
3. 兩側或中間：
 - 若症狀相似或病在正中（如任脈巡行線），按「男左女右」原則取穴。
 - 若症狀輕重不等，以嚴重一側為主證，取其對側施治。

18.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 胸悶一例（多經合治）：
 - 醫案要點：49歲女性，左側胸悶。
 - 辨證定位：三焦定位為上焦。涉及太陰、少陰、厥陰、陽明經。
 - 治則取穴：左病右治，取右手腕。選取右側太淵穴（太陰）、神門穴（少陰）、大陵穴（厥陰）、陽溪穴（陽明）附近阿是點。
2. 乳房脹痛一例（陽明、太陰、厥陰證）：
 - 醫案要點：36歲女性，雙側乳房脹痛，右側較重。
 - 治則取穴：以右側為主證，取左側。涉及乳房內廉（陽明）及整體區域。

- 選穴：左手太淵穴、大陵穴、陽溪穴附近阿是點。

3. 咳嗽一例（任脈、多經合治）：

- 醫案要點：48歲女性，咳嗽。
- 治則取穴：病在中間，按女右取右側。涉及太陰、少陰、厥陰、陽明及任脈。
- 選穴：右側手部太淵穴、神門穴、大陵穴、陽溪穴及通任脈之列缺穴附近。

18.4 四、練習題核心考點（第五節）

- 練習題場景：51歲女性，盜汗，病灶在兩乳房間（正中）及後背上部。
- 解題核心邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：胸部正中與後背上部均屬上焦（天部）。
 2. 二（辨經）：兩乳中間涉及任脈，後背上部涉及太陽經與督脈。因患者為女性，病在中間，首選右側。
 3. 一（找點）：在右側手部尋找列缺穴（任脈）與後溪穴（太陽/督脈）附近的同氣阿是點。

18.5 解說：醫療實務建議

處理胸部問題時，遵循以下專業指引：

- 安全性是第一法門：胸部與後背上部（肺尖所在）在傳統針灸中極易發生氣胸。內針將操作限定在腕踝區域，徹底杜絕了危險，這是極大的保障。
- 「乳房」問題的經絡重點：乳房問題多涉及陽明（胃）、厥陰（肝）與太陰（脾/肺）。臨床上，陽溪穴與大陵穴的同氣點往往是緩解脹痛的關鍵。
- 導引的配合：胸悶或咳嗽患者，進針後應引導其做「深呼吸」。如果呼吸瞬間變順、咳嗽頻率降低，說明同氣點（阿是穴）選取精準。

- **關於盜汗與上焦：**盜汗雖然涉及陰陽失調，但在內針各論中，若其表現與胸背症狀同時出現，仍可透過調整上焦相應經脈的「位」來引導陰陽自和。

第十九章 第十二章：腹部

腹部被視為「五臟六腑之宮城」，是人體精氣匯聚、運化與儲藏的核心區域。腹部診治不僅涉及脾胃運化，還與肝、腎、衝任等經脈息息相關。在黃帝內針的體系中，腹部的複雜性在於它橫跨了**中焦**與**下焦**兩個空間維度，這要求辨證與選穴時具備更高的精準度與靈活性。

19.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位（空間維度）：

- **中腹部**：以臍為中心，鳩尾穴至神闕穴（臍中）區域，屬於**中焦（人部）**。
- **下腹部**：神闕穴（臍中）以下區域，屬於**下焦（地部）**。
- **同氣部位**：中焦之病對應肘、膝關節區域；下焦之病則對應腕、踝關節區域。

2. 循行經絡（定性導航）：

- 腹部是經絡巡行最為密集的區域，醫者進針前必須明辨「病在此經」：
 - － **足太陰脾經**：入腹，屬脾絡胃。
 - － **足少陰腎經**：其直者從腎上貫肝、膈。
 - － **足厥陰肝經**：挾胃，屬肝絡膽。
 - － **足陽明胃經**：下膈，屬胃絡脾；其直者從缺盆下乳內廉，下挾臍，入氣街中。
 - － **足少陽膽經**：循脅里，出氣街。
 - － **任脈**：起於中極之下，以上毛際，循腹里。

19.2 二、腹部常用經絡同氣對應基準表

註：本表根據腹部三焦屬性及各論醫案綜合彙整，為臨床選穴基準點。

腹部經絡區域	臨床特徵	中焦同氣點 (肘/膝)	下焦同氣點 (腕/踝)
陽明經	胃脘痛、腸鳴、 腹部兩側痛	曲池穴、足三里 穴	偏歷穴、下巨虛 附近
太陰經	腹脹、腹瀉、臍 周痛	尺澤穴、陰陵泉 穴	經渠穴、商丘穴
少陰經	深層冷痛、遺尿、 冷汗	少海穴、陰谷穴	通里穴、太溪穴
厥陰經	少腹抽痛、氣滯 脹滿	曲澤穴、曲泉穴	內關穴、中封穴
任脈	腹部正中線、聲 音、生殖	中焦區域對應肘 膝	列缺穴、照海穴

19.3 三、醫案示例要點

1. 胃痛一例（中焦證）：

- 症狀：33 歲女性，胃部疼痛，位於腹部中間偏左。
- 辨證：病在中焦、左側。涉及太陰、少陰、陽明經。
- 治則：左病右治，取右手肘部同氣。
- 選穴：右側手部尺澤穴（太陰）、少海穴（少陰）、曲池穴（陽明）附近阿是點。

2. 下腹疼痛一例（下焦證與陰陽倒換）：

- 症狀：38 歲男性，右下腹疼痛。
- 辨證：病在下焦、右側。涉及太陰、厥陰、陽明經。
- 治則：右病左治。因病在下焦，原應取下焦（地部），但為便利與安全執行陰陽倒換，取左手腕部（天部）。
- 選穴：左手經渠穴（太陰）、內關穴（厥陰）、偏歷穴（陽明）附近阿是點。

3. 臍周疼痛一例（中下焦過渡證）：

- 症狀：12 歲女性，臍周疼痛。
- 辨證：臍周涉及中、下焦交界。涉及少陰、陽明、任脈。
- 治則：病在中間，女性取右側。執行下焦倒換至上焦。
- 選穴：右側手部通里穴（少陰）、偏歷穴（陽明）、列缺穴（任脈）附近各刺一針。

19.4 四、練習題核心考點

- 考題情境：一位 46 歲女性，主訴下腹發涼，伴有尿頻尿急現象。
- 解題邏輯（三二一規範）：
 1. 三（定位）：下腹部屬下焦（地部）。雖然可取踝關節，但臨床常執行陰陽倒換取腕關節（天部）。
 2. 二（辨經）：下腹與泌尿涉及少陰經（腎）、陽明經、厥陰經與任脈。病在正中，女性取右側。
 3. 一（找點）：在右側手腕部尋找通里穴（少陰）、列缺穴（任脈）、內關穴（厥陰）及偏歷穴（陽明）附近的阿是點。

19.5 解說：醫療實務建議

腹部是內針臨床中最能體現「陰陽倒換」智慧的部位。務必遵循以下指引：

1. 「位」的靈活轉換：腹部疾病多見於中下焦。記住，肘膝以上禁針。對於下腹部（下焦）的疾病，我們不一定非要在腳踝紮針，利用「下病上取」將其倒換到腕關節，操作更方便且氣機更靈敏。
2. 辨經要深，取穴要精：腹痛可能是胃痛（陽明）、腸痛（陽明/太陰）或痛經（厥陰/少陰）。診察時一定要手按患處，確診其受累經脈，否則同氣不合，療效全無。
3. 導引的即時反饋：腹部疼痛或不適，進針後應立即請患者「深呼吸」或「輕按腹部」。如果針法正確，患者應能即刻感覺到腹中的暖意或疼痛的消散。

4. **安全底線：**腹部臟器密集，傳統手法存在一定風險。內針透過在遠端肢體取穴，實現了對臟腑氣機的「隔空調節」，這對你們日後的執業安全是極大的保障。

第二十章 第十三章：手部

前幾章說明在「手部（肘、腕）」取穴來治療頭、眼、口、耳，那如果病灶就在手部自己身上，該怎麼辦？這一章揭示內針最精妙的空間投影與陰陽倒換智慧。掌握「手部」的治療不僅是為了解決局部的疼痛，更是為了深化「同氣相求」與「三焦座標」的理解。

20.1 一、主要概念與理論（第一、二節）

1. 三焦定位的雙重邏輯：

- **大三焦定位：**在整個人體中，手部（掌部）位於肢體末端，明確屬於上焦（天部）。
- **局部三焦劃分：**在手部與前臂的局部空間內，內針進一步細化了座標：
 - － **天部（上焦）：**腕部區域。
 - － **人部（中焦）：**肘部區域。
 - － **地部（下焦）：**肩部區域。
- **等分定位法：**臨床上亦可將腕部至肘部視為上焦，肘部至肩部視為中焦，肩部以上視為下焦。

2. 循行經絡與同氣基準：手部是六條經脈（手三陰、手三陽）的起點或終點，辨經的準確度直接決定了「引導相火歸位」的效果：

經脈屬性	循行與功能特徵	手部同氣穴位（基準點）
手太陰肺經	循臂內上骨下廉，入寸口，抵大指之端。	太淵穴、魚際穴
手少陰心經	下肘內，循臂內後廉，抵掌後銳骨之端。	神門穴、少府穴
手厥陰心包經	下臂，行兩筋之間，入掌中。	大陵穴、勞宮穴
手太陽小腸經	循手外側上腕，出踝中。	陽谷穴、後溪穴
手陽明大腸經	循臂上廉，入合谷，循指本。	陽溪穴、合谷穴
手少陽三焦經	循手背，出臂外兩骨之間。	陽池穴、中渚穴

20.2 二、針治法則（第三節）

在處理手部病症時，請務必內化以下實務準則：

1. 左病右治，右病左治：這是定格規範，不可違背。
2. 同氣定格：若症狀在手部的某個局部，則在對側對應的局部尋找阿是穴。
3. 陰陽倒換求：這是本章的進階核心。若手部（上焦/天）的問題在對側手部取穴效果不彰，可根據「上病下治」原則，倒換到足部的天部（足踝、足心區域）取穴。

20.3 三、醫案示例要點（第四節）

1. 右手網球肘（中焦/人部證）：
 - 病位：右手肱骨高點（肘部，屬中焦）。
 - 辨證：涉及陽明經、少陽經。

- **方案：**右病左治。在左手肘部尋找與右手痛點精確對應的區域進針。

2. 左手拇指髓鞘炎（上焦/天部證 + 陰陽倒換）：

- **病位：**左手拇指掌指關節（屬上焦天部、太陰經）。
- **辨證：**屬手太陰肺經。
- **方案：**左病右治。因手部操作不便或效果需求，執行「上病下治」，取右足。
- **選穴：**在右足太陰脾經之**大都穴**、**太白穴**附近尋找阿是點進針。

3. 右掌側麻木（上焦/天部證）：

- **病位：**右掌側。涉及**陽明經**（大腸經）區域。
- **方案：**右病左治。在左手陽明經之**陽溪穴**或**合谷穴**附近尋找同氣點進針。

20.4 四、練習題核心考點（第五節）

- **考題情境：**一位 26 歲男性，主訴右手食指、中指麻木。
- **解題邏輯（三二一規範）：**
 1. **三（定位）：**手指末端屬**天部（上焦）**。
 2. **二（辨經）：**食指涉及**陽明經**，中指涉及**厥陰經**。患者為男性，取**左側**。
 3. **一（定穴）：**在左手尋找**合谷穴**（陽明）與**勞宮穴**（厥陰）附近的同氣阿是點進針。若效果不顯，可思考倒換至左足對應區域。

20.5 解說：醫療實務建議

手部的治療是「投影」。臨床中，遵循以下專業建議：

- **「阿是」的精確位點決定成敗：**內針強調「相火以位」，手部解剖結構精細，你們在對側取穴時，必須用指尖仔細按壓，找到那個最有「神機」的敏感點。位定準了，相火才能發揮轉化效用。

- **靈活運用陰陽倒換：**如果患者右手受傷包紮無法進針，你們要立刻想到左手；如果左手也因故不便，要立刻想到右足。這種**四肢同氣**的互換是內針保障醫療安全與效率的法寶。
- **導引的配合：**手部疾患多涉及活動度。進針後，請務必引導患者「握拳、伸指、旋腕」。導引能實現「醫患共振」，引導氣血直接衝破局部的凝滯。
- **守住底線：**即便病在手部，也要遵循**肘膝以下進針**的規範（除急救外）。這是法脈，更是安全底線。

第二十一章 第十四章：足部

四肢末端與全身氣機巧妙聯繫。足部在黃帝內針的體系中，不僅是足三陰、足三陽經的起訖點，更是執行「上病下治」與「陰陽倒換」的核心陣地。這章建立完整的四肢投影觀；這章解釋如何在複雜的下肢痛症中，靈活運用三焦定位實現「隨手而應」。

21.1 一、主要概念與理論

1. 三焦定位的層次性（第一節）

- 大環境定位：足部位於人體最下端，在整體三焦中明確屬於下焦（地部）。
- 局部三焦劃分（關鍵投影邏輯）：
 - 天部（上焦）：踝部區域。
 - 人部（中焦）：膝部區域。
 - 地部（下焦）：胯部（臀/腹股溝）區域。
- 操作邊界：踝部至膝部可視為上焦（對應天），膝部至胯部視為中焦（對應人），胯部以上視為下焦（對應地）。

2. 循行經絡的路徑辨析（第二節）

- 醫者必須精確掌握足部六經的巡行，這是尋找「同氣點」的唯一依憑：
 - 足太陽膀胱經：從腰中下夾脊，貫臀，入臍中，出外踝之後，循京骨至小趾外側。

- 足陽明胃經：下髀關，抵伏兔，下膝臑中，下循脛外廉，入中指外間（2、3趾間）。
- 足少陽膽經：下循髀陽，出膝外廉，下外輔骨之前，直下抵絕骨之端，下出外踝之前，循足跗上，入小指次指之間（4、5趾間）。
- 足太陰脾經：起於大趾之端，循內側白肉際，過核骨後，上內踝前廉，上膝股內前廉，入腹。
- 足少陰腎經：起於小趾之下，邪走足心（湧泉穴），出於然谷之下，循內踝之後，別入跟中，上股內後廉。
- 足厥陰肝經：起於大趾叢毛之際，上循足跗上廉，去內踝一寸，上踝八寸，交出太陰之後，上股內廉。

21.2 二、足部經絡同氣對應基準表（核心參考）

本表根據內針總則與各論內容彙整，是大家日後行醫定位的「指南針」：

經脈名稱	足部病灶對應區域	手部同氣（對應）	足部同氣（對應）
陽明經	膝臑、脛外廉、2/3趾	合谷穴 / 曲池穴	陷谷穴 / 足三里穴
少陽經	膝外廉、外踝前、4/5趾	中渚穴 / 支溝穴	足臨泣穴 / 陽陵泉穴
太陽經	臑中、外踝後、小趾側	後溪穴 / 小海穴	申脈穴 / 委中穴
太陰經	膝股內前、內踝前、大趾	魚際穴 / 尺澤穴	太白穴 / 陰陵泉穴
厥陰經	膝股內廉、內踝一寸、大趾	勞宮穴 / 曲澤穴	太衝穴 / 曲泉穴
少陰經	股內後廉、內踝後、足心	少府穴 / 少海穴	太溪穴 / 陰谷穴

21.3 三、針治法則（第三節）

在醫療實務中，方位定格是「一針見效」的保證：

1. 左病右治：症在左足，取右腕（肘）或右踝（膝）同氣。
2. 右病左治：症在右足，取左腕（肘）或左踝（膝）同氣。
3. 中間或雙側：按「男左女右」取穴，或以嚴重側為主證取其對側。

21.4 四、醫案示例要點（第四節）

1. 踝關節扭傷（天部/上焦證）：

- 醫案：18歲男性，右外踝扭傷痛至足跟。
- 辨證：涉及陽明經、少陽經。病在上焦（天部）。
- 方案：右病左治。取左手腕部（天部）。
- 選穴：左手陽明經之陽溪穴、少陽經之陽池穴附近阿是點。

2. 膝蓋疼痛（人部/中焦證）：

- 醫案：65歲女性，左膝前側及內側疼痛。
- 辨證：涉及太陰經、厥陰經、陽明經。病在中焦（人部）。
- 方案：左病右治。取右膝對應區域。
- 選穴：右側陰陵泉穴（太陰）、曲泉穴（厥陰）、足三里穴附近阿是點。

3. 坐骨神經痛（地部/下焦證 + 陰陽倒換）：

- 醫案：50歲女性，右臀部後外側及大腿外側酸痛。
- 辨證：涉及少陽經。病在下焦（地部）。
- 方案：右病左治。因膝以上禁針，執行陰陽倒換，取左手腕（天部）。
- 選穴：左手少陽經外關穴附近刺入一針。

21.5 五、練習題核心考點（第五節）

- 練習題場景：35歲女性，左足自大腿至小腿前側麻木。

- 解題核心邏輯：

1. 三（定位）：大腿至小腿前側跨越中、下焦。
2. 二（辨經）：前側主要由陽明經所主。病在左，取右側。
3. 一（找點）：在右側手部（或足部）尋找陽明經同氣點。因跨度大，可在右側手部合谷穴至曲池穴連線的對應比例位置尋找阿是穴。

21.6 解說：醫療實務建議

足部及下肢醫療實務，務必遵循以下資深建議：

- 「阿是」的絕對精確度：足部骨骼肌肉結構厚實，患者疼痛往往非常明確。你們在對側同氣區（如腕踝或肘膝）尋找阿是點時，必須用拇指尖「地毯式」按壓。那個讓患者叫出聲來的酸痛點，就是氣血轉化的「開關」。
- 守住「肘膝以下」的法脈：這是內針的靈魂。即便病在臀部或大腿，也絕不在該處下針。透過「陰陽倒換」將其映射到腕踝或肘膝，這不僅是為了安全，更是為了利用經絡遠端的強大調節力。
- 導引的即時反饋：對於足部受傷或膝關節不利的患者，進針後一定要請他「試著下地走兩步」或「彎曲膝蓋」。導引配合針刺，能引導相火歸位，這也是內針最具魅力之處。
- 多經合治的果斷：下肢痛症（如坐骨神經痛）往往同時涉及太陽、少陽甚至陽明。臨床上不要拘泥於一經，應根據疼痛的分佈，果斷進行多經合治。

第二十二章 附錄：常用急救

22.1 第一節：毫針急救——理與法的核心

- 主要概念與理論：
 - 角弓反張：此類症狀多屬督脈攣縮，與太陽經、肝經密切相關。急救首選水溝穴（督脈之本）、後溪穴（督脈交會穴、太陽同氣）與申脈穴（太陽同氣）。
 - 中風急症：中醫將其分為「閉證」與「脫證」。
 - * 急閉證：與陽明經、厥陰經關係密切。陽明為多氣多血之經，針刺陽明（如合谷穴、足三里穴、陽溪穴）有助於促使氣血恢復。
 - * 急脫證：表現為神志不清、冷汗淋漓，需優先考慮少陰經與回陽救逆。
- 醫案示例要點：
 - 心臟病發作（心絞痛、心梗）：除針刺通里穴、少府穴、內關穴外，若手部抓握不便，可直接採取「強捏」太陰、少陰經絡方向。
- 練習題核心考點：
 - 若患者出現呼吸困難，應加刺哪些穴位以納氣歸腎？（答案：然谷穴、太淵穴）。

22.2 第二節：鋒針（三稜針）刺絡急救

- 主要概念與理論：

- **刺絡效用**：鋒針主要用於刺絡出血，對腦中風、癲癇急性發作有「先鋒」之效。
- **部位選擇**：首選百會穴、雙側耳尖、十宣穴（手指尖端）或氣端穴（足趾尖端）。
- **靜脈怒張處理**：若中暑急症，可在尺澤穴、委中穴附近尋找怒張的青筋刺絡放血。
- **醫案示例要點**：
 - **癲癇發作**：若神志不清顯著，可選用百會穴、雙側耳尖及十宣穴刺絡放血，以開竅醒神。
- **練習題核心考點**：
 - **刺絡急救時**，對於「四關」的定義除了合谷與太衝，內針還建議配合哪兩個穴位？（答案：內庭穴、陷谷穴）。

22.3 第三節：艾灸急救——回陽救逆

- **主要概念與理論**：
 - **適用症**：主要用於「脫證」，症見面色蒼白、手足冰冷、大汗淋漓、脈微欲絕。
 - **救治原則**：以回陽救逆為要，艾灸是最迅速的選擇。
- **醫案示例要點**：
 - **脫證急救**：優先選用勞宮穴、湧泉穴、神闕穴、關元穴、氣海穴進行艾灸。

22.4 第四節：指掐或提捏——無針時的應變

- **主要概念與理論**：
 - **指代針法**：在匆忙無針具時，指掐穴位（如水溝穴、合谷穴）能爭分奪秒完成急救。
 - **撥動大筋**：這是內針最具特色的急救手法。

1. **極泉穴撥動**：中指在腋窩極泉穴處，將肌肉向後推然後向前撥動，患者若有如「電擊感」傳至手指，說明手法正確。
2. **腋前大筋提捏**：用於治心臟病急性發作，如心絞痛、心梗，連續提捏 6-9 次。

22.5 核心急救技術彙整表

急救類別	核心病機	推薦穴位名稱 (必須精確)	推薦操作方法
開竅醒神	癲癇、中風閉證	水溝穴、百會穴、 十宣穴	毫針深刺或鋒針 刺絡
回陽救逆	脫證、虛脫、大 汗	湧泉穴、神闕穴、 關元穴	艾灸或指掐
宣通心絡	心絞痛、心梗	內關穴、勞宮穴、 極泉穴	毫針針刺或撥動 大筋
納氣定喘	呼吸困難、氣絕	然谷穴、太淵穴	毫針針刺
熱病中暑	昏倒、體溫高	委中穴、尺澤穴、 中衝穴	尋青筋刺絡放血

22.6 導讀：醫療實務建議

急救現場瞬息萬變，請記住以下三條原則：

1. **「位」是關鍵**：即便在急救中，定位（同氣）依然是核心。例如心臟病取少陰、厥陰，腦部病變取八邪、八風。
2. **不拘一格**：內針雖然有針刺規範，但急救時要針、灸、掐、捏、撥並用。特別是極泉穴撥動法，在處理突發心源性問題時往往有奇效。
3. **神與形俱**：急救時醫者必須鎮定（守神），透過精確的手法（守形）來引導患者氣機。若針後效果不明顯，應迅速採取調針、補針或陰陽倒換。

